

ראיונות בביטוח לאומי מחקר השטח

מראיינת מספר 1

1.

עו"ס, 5 שנים במחלקת סיעוד, פעם קצין מבחן למבוגרים. יש לו 2600 מטופלים, חסרים תקנים. סניף רחובות- נותן שירות להרבה רשויות, ערים, יישובים, קיבוצים- מאפיינים שונים וצרכים שונים. מאמין ופועל בשיתוף פעולה עם מש"ח, קופות חולים וגורמים נוספים בקהילה. גמלת הסיעוד היא כלי לרווחה של האזרחים הותיקים, וזה מצריך שיתופי פעולה.

גמלת הסיעוד ברמה 1, 2- היא קצת טריקית, אנשים ברמות האלו עם צרכים נמוכים. הרבה אנשים שיוצאים לעבוד ברמות האלו. בהינתן הקשיים הכלכליים כיום, הגמלה משמעותית עבורם, יותר משירותים בקהילה, במיוחד כשיש משפחה שתומכת. במצב הזה, אנשים מתרגלים שגמלת הסיעוד היא הכנסה נוספת. משמעותי ומפתה, אך זה משאיר את האזרח הותיק בעתיד ללא עזרה, לא יידע לקבל עזרה. יש אנשים שהמעטפת החברתית שלהם דלה, הם יחשבו על לקיחת שירות, גם המשפחה תדחוף.

מאוד תומך בקהילה תומכת- עוד משהו רואה אותם. נותנת מענה חברתי ותרבותי. קשה לאנשים לצאת מהבית, בעיקר אנשים עירוניים. גמלת הסיעוד בהכרח פוגע בפרטיות שלך, וזה לא פשוט לאנשים. ברמה 1, 2 יש פחות קושי, אז הוא פחות ירצה לפתוח את הפרטיות שלו. ברמות יותר גבוהות הם כבר רגילים לפתוח את הבית לאנשים זרים.

המטפל מגיע והאזרח הותיק מצפה שהוא ינקה. המענה צריך להיות טיפול ולא משק בית. אנחנו בתהליכים בפיתוח המענים של המטפל, עוד מיומנויות. האזרח הותיק הוא בודד, ומטפל שגיע עם עוד מיומנויות.

סטיגמה, יציאה מאזור הנוחות של חברות הסיעוד. יש לנו הרבה בעיות עם חברות סיעוד, יש מטפלות טובות ומסורות.

בני משפחה מטפלים- קשה להם להתמיד בטיפול. הם עושים את זה בין לבין. זה לא פשוט. אנשים כבר לא רוצים להיות בן מטפל כמשרה. יש כאלה שזה טוב להם. הפיקוח הוא חשוב. חברות הסיעוד לא תמיד עושים את העבודה שלהם. הדו"חות לא אמינים לפעמים. חשוב לעמוד בסטנדרט של ביקורי בית ופיקוח.

תהליך לאחר קבלת הזכאות- מציגים שגמלת הסיעוד מציעה שירותים, מסבירים מהם אותם השירותים ומציעים גם גמלה בכסף. לא מעט אנשים מבקשים שירותים, הוא משתדל שייקחו קהילה תומכת, הם עושים עבודה טובה יותר מחברות הסיעוד בבקרה. לאחר מכן, אנחנו עושים ביקורי בית, להכיר את האזרח הותיק. ההיכרות עם האזרח הותיק מאפשרת להבין מהם הצרכים שלו, וכך להציע לו שירותים מתאימים.

מרכז יום- רמה 1, 2 לא לוקחים את השירות הזה. השירות הזה הוא לזקנים. חברת קיבוץ בת 93- "מרכז יום זה לזקנים". כל מי שהולך למרכז יום, לרוב לא עוזב. שירות מאוד משמעותי. בעיה בשיווק, אם היה אפשר לשווק את זה כמתנ"ס למבוגרים, עם חוגים והרצאות, היה נראה אחרת וצעירים יותר היו מגיעים. בקיבוץ עין צורים, יש להם מוסד ממכללת הרצוג, האזרחים הותיקים מחוץ לקיבוץ מגיעים, מעשיר את הדעת.

גמלת הסיעוד לרמה 1,2-

1. צרכים- מטפלת, מוצרי ספיגה, כסף למנקה, למוניות, לתרופות.
2. אלטרנטיבה חזקה שמשווקת טוב, בבניין שנראה טוב, שירותים בקהילה במקומות כאלו זה יכול למשוך הרבה אזרחים ותיקים ברמות 1,2. בעיקר בערים. קיבוצים- לעבוד עם הוועדות והמש"ח לקבל תקציבים מותאמים להם כדי לתת להם מענים.

העבודה עם המש"ח:

הבטל לא היה רגיל לעו"ס סיעוד.. הקשר מאוד טוב עם המש"ח. בודק כל בוקר עם הרווחה פנו אליי. מראה שהוא מעורב, חשוב לו. יש עו"ס מש"ח עם גישות בעייתיות, "מה נשעה, מה אפשר לעשות". הם שותפים מאוד משמועתיים.

יצרו מנגנון- פגישה פעם בחודשיים, לא מציאותי. בסוף זה תלוי בן אדם, מה הגישה שלו.

Follow-up:

80%- לא פונים אליהם שוב, יש להם משפחה, לא עולה בעיות חריגות

20%- יש כאלו שאנחנו איתם במעקב.

בגלל ריבוי האנשים השירות לא אישי. ביטוח הלאומי ניסה להביא עו"ס פרילנסרים לביקורי בית. זה מהלך מאוד חשוב.

- חוץ מקהילה תומכת אין שירות משמעותי עבור רמה 1, 2.
- אין מנגנון ברור לשת"פ עם הרווחה
- שירותי סיעוד: פוגע בפרטיות של האזרח הותיק

2.

כל חברי הצוות עצמאיים בשטח בקהילה. יש להם תקשורת ישירה עם הגורמים בשטח.

21 אלף זכאים- רובם דוברי ערבית. הכפלנו את הזכאים בעקבות הרפורמה. 20 אנשי מטה. 40 אחים ואחיות בשטח, בודדים מרפים בעיסוק. כמעט 60 אנשים בצוות שלה. מאוד חשוב לה שאנשי הצוות יגיעו לקהילה.

כל חברי הצוות יודעים את כל תחומי האחריות בתוך הצוות וכך משלימים אחד את השני.

יועצים ומערכים- אומדן הרפואי של הקשיש. בשיחה טלפונית עם הקשיש. במידה ויש צורך בביקורי בית אז נעשה את זה. למרות שהקשישים מעדיפים לרוב מרחוק. הכל מתועד, לכן יש צורך במסמכים רפואיים. ואז יש זכאות. ביקורי בית זה יותר מורכב. יש שיקול דעת של היועץ. המעריך מכין את ההערכה ומעביר ליועץ. זה המקום של היועץ להפעיל שיקול דעת, שולח הערות למעריך במידת הצורך. יש מקרים שבהם היועץ עושה את התפקיד של המעריך, ומגיע גם לביקורי בית. שיתוף של מסמכים רפואיים ושיחות טלפון מצמצים את העומס. תוך 8 ימים התיק סגור ומקבלים את הזכאות.

הגיל הוא לא אומדן לקבלת קצבה. השיקול דעת של הפקידה משמעותי כאן.

בסוף התהליך התיק מגיע לעו"ס. העו"ס מנסה לסגור תכנית עם הקשיש. מציגים לו את השירותים ואת הזכויות שלו + ביקורי בית. בכל רגע נתון הקשיש יכול לפנות חזרה לביטוח לאומי ולשנות את התוכנית. יש לנו נתונים על הפניות. 150 פניות מוקד, 50 פניות ציבור. בסופשים פונים יותר, המשפחה נמצאת איתם בימים אלו.

רמה 1, 2 פחות עושים ביקורי בית, יש סטנדרטים לביקורי בית, מפעילים שיקול דעת מתי הולכים לביקורי בית. ביקור בית רבע שעה, 20 דקות.

אוכלוסייה בריה"מ, אוכלוסייה יותר קשה, הביקורים יותר ארוכים, קושי במציאת כוח אדם. אוכלוסייה שקשה לה לצבור אמון.

בתקופת הקורונה אימצנו ביקורי בית בזום. הדור החדש של הזקנה יודע להתמודד מול טכנולוגיה.

איכות החומר של מסמכים רפואיים ושיתופי פעולה עם קופות חולים- הם אלו המקשים בתהליך ופוגעים בייעול שלו. אין לנו עדיין אפשרות להתחבר לתיק הרפואי של הקשיש. חיבור כזה יכול לייעל בצורה משמעותית.

קשישים רצו ללמוד קורסים של דיגטציה. מעודדים במרכזי יום. יש הרצאות באתר של הביטוח הלאומי.

פרוייקט עם הג'וינט- להגיע לכמה שיותר זקנים בקהילה, שיתופי פעולה עם הבטל"א, עם המש"ח, קופות חולים.

שתף עם המשח- ערוץ טכנולוגי פתוח- הם יכולים לפנות אלינו. הם שולחים אליהם אזרחים ותיקים עם בעיות ספציפיות כדי שיטפלו בהם. וגם להפך. יש לנו ועדות היגוי- מרכזי יום וקהילה תומכת. עדיין יש קושי בבירוקרטיה ביניהם. אין מספיק מצדם לאתר אזרחים ותיקים, הם נשענים עם ביטוח הלאומי. עבודת השטח היא עליהם. יש גם אתגר של הכסף וכוח אדם. אנחנו לא מבינים את הנהלים שלהם. מתמודדים עם אטימות לפעמים. זה מאוד תלוי אנשים ורווחה. ניכר שיפור משמעותי ביחסים ובשתף.

רמה 1,2, באחת הערים אחוז האנשים שלוקחים רק כסף הוא נמוך. הרבה מעדיפים גמלה משולבת. אפילו אלו שלוקחים רק כסף, חוזרים אחרי כמה חודשים וצורכים שירותים. ברמות האלו, נראים עצמאיים אך יש להם קשיים שלא נראים בעין.

היום השירות הרפואי מאוד יקר- השלמת ההכנסה לא מספיקה. בתקופת הקורונה, נתנו תוספת לארוחות, זה היה מאוד משמעותי. יש כאלה שאין להם ארוחות חמות ביום יום. עו"ס פותחים מקררים ריקים.

היום קשה למצוא את מטפלות שיממשו את כל השעות. הוא מבין שמגיע לו 10 שעות, המודעות גבוה יותר, יש להם יותר אומץ הם משתפים אותנו במידה ומנצלים אותם בשעות טיפול ופחות "פראיירים". אין מספיק ביקורי בית בנוגע לטיפול וסיעוד.

יש סעיף מוגן בחוק לעו"סים קבלן שיהיו מפקחים בשטח.

האתגר החדש- התאמת השירותים לזקנים של הדור החדש. הם לא מגיעים למרכזי יום. המסלולים הקלאסיים שבמרכזי יום כבר לא מעניינים אותם.

רעיונות-

1. פרא רפואי- עולה צורך. ספורט שמותאם לגילם.
2. שילוב הטכנולוגי

פורום- פעם בחודשיים או ברבעון. כנסים רוחביים. אנחנו מציפים את זה. מידת ההשפעה לא מספקת. יש שיח אך לא בא לידי יישום או שאנחנו לא יודעים על כך. אנחנו לא יודעים אם עושים עם זה משהו בהמשך.

הנגשה תרבותית- הסניף שלנו מעורב. יש קשיים ופחות מתייחסים להנגשה הזאת.

מראיית מספר 2

1.

נותן שירות גם לערים וגם למועצות אזוריות כך שיש אוכלוסיות שונות ומגוונות תחתיו.

פועל בשיתוף פעולה עם מחלקות רווחה, גורמים בקהילה, קופות החולים. רואה את גמלת הסיעוד ככלי בתוך פול המענים ולכן רואה חשיבות בשיתופי הפעולה.

גמלת סיעוד ברמה 1 ו2 היא טריקית כי אנשים ברמות הזכאות האלה הם עם צרכים נמוכים בעזרה ובתמיכה, יש אנשים שגם במקביל יוצאים לעבוד, ובהתייחס לקשיים הכלכליים בכל שכבות האוכלוסיה היום, אנשים לוקחים כסף. זה גם פוגע בלקיחת שירותים בדרגות הסיעוד הבאות כי כבר התרגלו להתייחס לזה כגמלת אזרח ותיק שניה, ומשאיר את הזקן בהמשך הדרך בלי עזרה שבאמת הוא זקוק לה. כן רואה שכשחסר קהילה לוקחים שירות.

תומך נלהב של קהילה תומכת, תמורה גדולה בעלות נמוכה- גם זרה פרקטית וגם מענה תרבותית וחברתית.

באופן כללי יש משהו שפוגע בפרטיות בלקחת שירותים וזה עוד חסם בלקחת שירותים. מהלך חשוב היום- מטפל מיומן בשיתוף הג'וינט, כדי להרחיב את תפקוד המטפלת כדי שלא ינקה אלא יעשה את מה שבאמת צריך. חברות סיעוד לא שותפות חיוביות במהלך כרגע.

בני משפחה מטפלים זה גם טריקי. לילדים קשה לתת את המענה בהתמדה, הוא עושה את זה בין לבין וגם קשה להחליף מקום מילד לעובד, קשה רגשית. גם ההורים לא יתלוננו על ילדים אם הם מעגלים פינות וכו'. אם יש אלטרנטיבה צריך שיהיה מטפל מהמאגר מטפלות, אבל בסדר שיש את האופציה אם אין אלטרנטיבה. אבל צריך להגביר פיקוח, גם לא בנוכחות הילד ויותר מעמיק.

מחקר של ד"ר איילה ____ מבר אילן על בני משפחה מטפלים.

מעמד קבלת גמלת הסיעוד- מתקשרים אליו, מסבירים מה הזכאות שלו, מה מגיע לו, מסבירים שזו גמלת שירותים ומה אפשר לקבל תמורתם. מסבירים שאפשר לקבל גם את הגמלה בכסף ולרכוש שירותים באופן עצמאי. לא תמיד בוחרים בכסף, לפעמים גם בשירותים, הוא דוחף בעיקר קהילה תומכת. הם אומרים במה הם בוחרים. יותר מאוחר מגיע גם לביקור בית שמתנהל יותר בנחת והוא משתדל לקחת יותר מידע, להבין את עולם הערכים ומה חשוב לו. ככה יגיש לו בצורה טובה יותר את השירותים ויתאים לו אותם.

מרכז יום הוא שירות משמעותי עם שיווק בעייתי. מי שמגיע אוהב ולא עוזב מרצון אבל צריך רמה מסוימת של סבל כדי להרשות לעצמך ללכת לשם. צריך מיתורג מחדש, להוציא את זה מהרווחה במובן מסויים. לתת שירותים מאתגרים אינטלקטואליים.

שני צירים ברמה 1-2: ציר הצרכים הקונבנציונלי (מוצרי ספיגה, מטפלת, קהילה תומכת, אפילו מנקה, מוניות, תרופות) וציר שני זה ציר של שירותים שמוגשים באופן יוקרתי, משווקים היטב ושלא גורמים להם להרגיש מסכנים. בעיה בעיקר בערים, פחות במרחביות. במרחביות מציע שיתוף פעולה עם רכזי בריאות ורווחה בישובים ולעבוד איתם ולהקצות תקציבים לטובת פעילות בישוב.

עבודה עם מחלקות הרווחה: ההתחלה הייתה מקרטעת בעיקר בגלל בטל"א שלא היה רגיל לעובדים סוציאליים בחזית. התהליך היום של הקשר יותר פשוט. רואה ברווחה שותפים על מלא. לפעמים התחושה היא שעם אנשים מסויימים ברווחה היא חוסר אוניס וזה גורם לו לקחת עליו אחריות שלו.

אמורים להיפגש עם הרווחה כל חודשיים שלוש, יש לו 6 לשכות רווחה וזה יותר מדי. הוא כן בקשר מתמיד איתם אבל הפרוטוקולים לא ריאליים. כן נשען הרבה על החומר האנושי. זה קשה גם כהוא אחראי על 2600 מטופלי רווחה!!!! ברווחה יש עוד יותר עומס. בהתאם, לא בבדיקה מתמידה על כל המטופלים. במעקב אחרי מספר מוגבל של אנשים שמבחינתו מועדים לפורענות.

בחזון של בטל-א תיחזק ע"י ביקורי בית של עו"סים פרילנסרים במקומות הבעייתיים.

2.

שנה בביטוח לאומי, התחילה מהבטחת הכנסה ומ2018 עברה לנהל את סיעוד. נתן לה ראייה אחרת על נושאי השירות והחשיבות של השילוב של זקנים בטכנולוגיה. לא מהעולם של עבודה סוציאלית, יותר עולמות החינוך והיזמות והכלכלה והסטטיק=סטיקה.

יש לה 21 אלף זכאים בעיקר דוברי ערבית, אזור גיאוגרפי רחב מ. הכפילו את אחוז הזכאים מ2018. 20 אנשי מטה, 40 אנשי שטח אנשי רפואה. עובדים על בסיס עצמאות מקצועית.

כל אחד מהעובדים אמורים להכיר את השירותים ולשווק אותם.

הפקידה מקבלת את התיקים שהוזנו ע"י פקידי הקבלה ומעבירה למעריכים. תוך 8 ימים צריכים לספק תשובה מרגע הגשה עד קבלה. בממוצע תוך שבועיים שיחה למבוטח עם מה שמגיע לו, ממוצע ארצי 38 ימים. כמשתאר זה בגלל חוסר בחומרים מקופות החולים בדרך כלל.

היועצים והמערכים במטה- המעריכים עושים אומדן תלות בשיחה טלפונית ואם יש צורך מוסיפים ביקור בית אבל רוב האזרחים הותיקים מעדיפים שיחת טלפון. אבל ביקור בית זה גם מיותר כי מה

שקובע זה מסמך מקצועי גם אם זה סותר את מה שיש בשטח. כן יש שיקול דעת מסויים, לכן לכל מעריך יש גם יועץ שאמור להעביר בקרה את הדוחות של המעריכים. גם היועץ יכול לעשות הערכת תלות ואז זה לא עובר אצל עוד גורם.

פקידות- עובר אליהן ההערכה של היועצים והמעריכים, אבל יש סיטואציות רפואיות שכבר במעמד קבלת התביעה הן יכולות לקבוע שמגיעה תמיכה וזה מוריד עומס משמעותי מהיועצים והמעריכים, נותן שירות טוב יותר לקשישים. יש לה גם מקום לשיקול דעת מעבר לחוק, מקום אנושי סוציאלי רפואי למשל כן להתייחס לגיל למרות שלא אמורה.

אחרי כל התחנות האלה התיק מגיע לעובד סוציאלי שאמור לעשות את השיחה הראשונית עם המבוטח ולסגור איתו על תוכנית עקרונית, להסביר על השירותים שמגיעים לו וגם קובע איתו ביקור בית ראשוני. מסבירים להם שהוא יכול בכל זמן לשנות את סל השירותים. כל ביקור בית יש שעה. לא מספיקים ביקורי בית לכל הזכאים, חייבים לפחות 40 בחודש לכל עו"ס. שיחות הטלפון מוערכות בערך ברבע שעה-20 דקות. לרוסים יותר ארוך כי אוכלוסיה מאתגרת גם מבחינת שפה וגם בגלל אי אמון במערכת.

יש התלהבות מהקשישים הצעירים יותר מהשירותים הטכנולוגיים שמציעים, כולל למידת טכנולוגיה.

יש עלייה כללית בערוצים הדיגיטלים, ביניהם גם עלייה בשינוי של תמהיל השירותים אחרי קבלת הכרה, כלומר מתאפשר דיוק של הצרכים עם הזמן.

ערוץ טכנולוגי פתוח של המש"ח לביטוח לאומי. הרווחה מדווחת על אנשים כדי שיטפלו בו בביטוח לאומי. הביטוח הלאומי גם לפעמים מבקש מהרווחה מידע לא רשמי או גישה למבוטחים שחסר עליהם מידע. יש ועדות היגוי משותפות שעוסקות בקהילה תומכת ומרכזי יום, יש ניסיון לפתח עוד דברים ביחד. יש עדיין קושי בתקשורת לפעמים, פועלים קצת שונה. היא מרגישה שאין מספיק מאמץ להביא מידע מהשטח והרווחה נשענת על ביטוח לאומי. יש גם אתגר של כסף, תקציבים, כוח אדם. חסר לבטל את הנהלים של הרווחה, לא ברור מה מותר ומה אסור, מה בסמכותם ומה לא. זה בשוליים, היחסים הולכים ומשתפרים.

ברמות ההכרה הנמוכות יותר לוקחים שילוב של כסף ושירותים מאשר רק כסף. מבינה את הצורך בכסף. עולה המודעות של הקשישים כלפי מה שמגיע להם, אומץ לשתף אותם במה שעובר עליהם, עוזר לעשות התאמות תוך כדי.

אתגר- התאמת סל השירותים לאוכלוסיית הזקנים החדשה. פחות אנשים מגיעים למרכזי יום וקהילה תמוכת. להכניס יותר פרא-רפואי לשירותים שמוצעים, ספורט שמותאם לגיל השלישי, אוריינות טכנולוגית. אין לבטל"א באמת יכולת להשפיע על השירותים שניתנים ע"י הרווחה. הם רק יכולים להציע אבל זהו.

חשוב לה גם להעלות את נושא ההנגשה התרבותית והחשיבות שלה.

מראינת 3

1.

מאוד מאמין ופועל עם מחלקות רווחה וקופות חולים וגורמים נוספים כמו עמיגור מאמין בזה כי הראייה שלו את גמלת סיעוד ככלי בתוך פול המענים ולכן חייב גם שיתופי פעולה.

גמלת ברמות 1+2 היא קצת טריקים כי הצרכים של אנשים ברמות האלה הם נמוכים ואפילו חלקם עוד יוצאים לעבוד – שומר, מענה משרדי ובהתייחס למצב הכלכלי הקשה ויוקר המחיה והצרכים הרבים שעולים לזקנים וילדיהם – הם מעדיפים לקחת את זה בכסף בייחוד כשיש בני משפחה שעוזרים להם ואז זה הולך למקום של כסף, ואז זה פוגע גם בהמשך כשהם עולים ברמץ סיעוד וכבר התרגלו שגמלת

סיעוד זה גמלת אזרח ותיק מוגדלת, וגם מונע מהם להתרגל להיות גורם שמקבל משתמש ונהנה מעזרה

ברמה 1 הרבה בלי להתלבט לוקחים כסף, אבל מי המעטפת שלו חלשה וחסרה לו קהילה אז הם ולפעמים הילדים ידחפו לקבל שירות

הוא מאוד אוהב קהילה תומכת נותן הרבה תמורה בעד עלות קטנה הוא מנסה לשווק את זה כל הזמן הם צריכים להעיז לצאת מהבית – בעיקר אנשים עירוניים שרגילים לפרטיות ולהיות בבית

כל הנושא של שירותים בגמלת הסיעוד גורם לאנשים לאבד פרטיות וצריך לסבול הרבה כדי תסכים לאבד את זה כשאתה מכניס מטפלות הבייתה ועוד הן מתחלפות. המעבר מאדם עם שליטה וחירות ומעגלים חברתיים שיכולת יותר לבחור איך לווסת ופתאום אתה חדיר.

ברמה 1+2 יש פחות זבל אז זה פחות גורם לאדם לא לבחור בשירותים

בקיבוצים ומושבים יותר קל להם לבחור שירותים כי החיים יותר קהילתיים מלכתחילה ויש יותר תנועה בבית

ועד שכבר מגיעה מטפלת אז הם רוצים שהיא תעבוד – וכל הזמן רוצים ניקיונות צריך לגזור תא המענה מהצרכים וזה לא קורה היום

מטפלת מיומנת – בשיתוף הג'וינט להרחיב את התפקוד של המטפלת ואנשים צריכים להעז לטעום מהדבר הזה

בסוף אנשים לבד בעיקר בערים אבל גם במושבים, פחות אנשים רואים מה איתך והמטפל המיומן שמגיע הבייתה ועושה דברים אחרת זה דבר שהוא מאוד חשוב – צריך שינוי עמוק של סטיגמה ויציאה מאזור הנוחות של חברות הסיעוד שעושים דילים חשבוניות מזוייפות

בני משפחה מטפלים זה טריקי – זה הרבה פעמים יותר נוח להורה אבל הילדים קשה להם לתת את המענה בהתמדה הוא עושה את זה בין לבין לפני ואחרי העבודה ובהינתן אילוצי חיים ומעבר לזה שנתקל בבני משפחה מטפלים שלא רוצים את זה יותר – לא רוצים את המחוייבות ולהיות עובד של אמא זה לא בריא להם

יש כאלה שזה ממש מתאים להם אבל זה מורכב ואמא לא תללון על הבת – לא עושים עסקים עם משפחה – זה לפעמים אלטרנטיבה יחידה אבל זו צריך להיות מוצא אחרון והתפקיד שלהם ושל חברת הסיעוד זה לפקח על הדבר הזה והוא לא בטוח כמה חברת הסיעוד עושה את זה

וצריך להעמיק את הדוח בקרה – ביקור יותר ארוך – לא בזמן שבן המשפחה המטפל נמצא – צריך לחזק את הסטנדרט של ביקורי הבית של חברות הסיעוד – מה שואלים איך מתכוונים, איך יוצרים ערוצי תקשורת חופשית עם האדם, לפעמים מצליחים לשכנע לשלב בין מטפלת לבן משפחה.

יש פה סיכון להזנחה שקטה

בדרכ מתקשרים למי שקיבל זכאות, מסיבירים מה הזכאות שקיבל והמשמעות ושזו גמלת שירותים ומה השירותים האפשריים ומסבירים שברמה 1 אתה יכול לקבל גמלה בכסף ולרכוש שירותים באופן עצמאי ואז האדם בוחר -קשב לורמ שברוב הפעמים בוחרים כסף, יש הרבה מקרים של בחירת שירות והא משתדל שזה תמיד יכלול קהילה תומכת, זה מקור מידע טוב גם עבורו, אם חברות הסיעוד היו עושות בקורות טובות היה לו יותר נוח. עושים תכנית בהמשך מגיע לביקור בית יש שיחה יותר בחת, לומד עליו

ומכיר אותו ודע איך להנגיש לו יותר וב את השירותים שפתוחים לו. מרכז יום הוא שירות נהדר שלא ככ מתאים למרכז יום – כי שם זה זקנים

אבל מי שכן הולך בדרכ לא יפסיק כי נהנה אלא אם יש הכרח להפסיק ללכת

יש אנשים במעצר בית שנים מרותקי בית כמו תחנה אחרונה אם אין מישהו שיגיע אליו לעזור לו הוא לא יפגוש אפחד.

יש בעיה רצינית בשיווק של מכרזי יום אם היה אפשר לפתוח מתנס לגיל המבוגר – חוגים, פעילויות, הרצאות שכמו שמשלמים שעתיים למרכז יום ישלם לבוקר או אחהצ של פעילות כולל הסעות כי אני מרגיש פעיל ולא חלק מהזקנה של מרכז יום

במרכז במכללה באזור פתחו מרכז של הרצאות ופעילויות ומגיעים לשם מכל הסביבה, מעשיר אותם ומאתגר אותם. זה גם צורך שלהם להרגיש משמעותיים ומסוגלים זה דבר מאוד חשוב

הוא חושב שגמלת הסיעוד ברמות 1+2 צריכה ללכת בשני הצדים

צירה אחד זה הציר של הצרכים הרונבציונאללי-קהילה תומכת, מטפלת, ניקיון וכוויכול להיות שצרכים כסף להביא מנקה כי לפעמים זה הצורך הנפשי שלה, כסף למוניות וכו, תרופות

ויש אנשים שידשדשו בדברים האלה וזה

אבל צריך ליצור אלטרנטיבה חזקה שמשווקת טוב, בבניין שנראה טוב, לפעמים זה נופל על העולב של המתקנים, אין אנשים עצובים במגדלי הים התיכון – התחושת יוקרתיות חשובה.

אם רמות 1+2 יוכלו לצרוך שירותים כמו מגדלי הים התיכון בקהילה זה יהיה שינוי משמעותי זה יחזק אותם, רלבנטי בעיקר בערים. בקיבוצים ומושבים זה מורכב בגלל המרחקים – היה ממליץ לשתף עם הרווחה של הועד ביישובי לכל קיבוצן ומשוב יש רכזת ואפשר לעבוד איתם בשיתוף הרווחה להקצות להם תקציבים ויכולו לתת מענים בסביבה שאנישם חיים לפי הההיכרות והרצונות והצרכים של האדם

ההתחלה של השתף עם הרווחה היתה מקרטעת כי זה היה חדש, כל שאלת העברת המידע היתה מורכבת, היום התהליך הרבה יותר פשוט

גם ברמה ההגיונית יש לו ויתור סודיות הוא יכול למסור ולהעביר מידע, הקשר מאוד טוב עם הרווחות רואה בהם שותפים על מלא, הדבר הראשון שעושה ביום זה לבדוק אם יש לו פנייה מהרווחה, הוא מזמין אותם לביקורי בית ולפעמים מרגיש שמעיר אותם כי גם הם בקבועות, יש עוסיות מסויימות שנקודת המוצא שלהן היא מה אני יכולה לעשות (בקטע רע – אין לי מה לעשות) ואז הוא נהיה הקייס מנג'ר במקומה ומניע לביוקר בית ומשף את קופח.

גמלת הסיעוד בעיניו היא מנוע לשינוי שהוא עושה יחד עם הגורמים בקהילה הוא לא מתנוק מהם.

יש מנגנון רשמי שהוא לא מציאותי של פגישות כל חודשיים שלושה, הוא עובד מול 6 לשכות שונות זה קשה אבל הוא כן משתדל קשר ישיר ורציף איתם.

הרבה פעמים הוא צריך לדחוף את עצמו אבל רוב העוסיות ברווחה מסורות ומחוייבות לתפקיד. יש לו 2600 מטופלים חייבים עוד תקנים אם רוצים מענה יותר עמוק וסבלני

70% לא חוזרים לעוד פולוא אפ למקבל השירות אלא אם תהיה פנייה מצידו אבל יש כאלו אולי לא 30% פחות שאתה במעקב איתם ולפחות פעם בשנה תדבר איתם. בגלל ריבוי האנישם השירות הוא פחות אישי.

בחזון שירותים של ביקורי בית של עוס פרילנסרים לתחזק את הנושא הזה. לפעמים יגיעו קשיים דרך קופח, רווחה הוא רואה בהם סוכני שטח שלו שמתרעים בפניו על דברין ומקפצים לו איורעים

2.

מדריכה מפקחת – מנהלת מקצועית של העוס" – יש 6 עו"ס במחלקה. עיר מזדקנת. לכל אחת 2500 זכאים לחוק סיעוד. מחולקת לרבעים וכל אחת אחראית על הרוב גם במחינת זכאים וגם במחינת מיפוי שירותים בקהילה ברובע שלה גם קופח, מתנסים, מועדונים וכו'. כל עו"ס יודעת מה קורה בגזרה שלה ויודעת לנתב. הן מיישמות את החוק לאחר אישור. הן בונות את תכנית הטיפול גם בליווי אישי וגם מול הספקים. דואגות שהתכנית תהיה מיטבית ומותאמת – ביקור בית לרוב המוחלט של החדשים תוך חודש מיום קבלת הזכאות ולאתר חריגות.

עושות התאמות בהתאמת לרמת זכאות ומעטפת משפחתית.

ביקור ראשוני 30 יום אחרי זכאות ומאותה נקודה נכנס נותן השירותים של גמלת הסיעוד גמלה בעין בדרכ חברת סיעוד ואז יש ביקור בית של עובד מקצועי של החברה אחת לחודשיים. לא ידיעו לביקור בית נוסף למעט במקרים כמו חשד להזנחה או הטרדה מינית אגרנות החמרה ללא גורם מסייע (עיריות סכסוך משפחתי)

השאפה שלהן לא להשאיר אנשים בלי שירות בכלל רק כסף או כסף ולחצן מצוקה משתדלים לא להשאיר מישהו בלי שום שירות

רמה 1 מאז הרפורמה יש להם אפשרות רק בכסף – כחלק מהתביעה מוצגת כאשפרות תמיד בשקיפות מלאה, אנשים די מתפקדים בעיות רפואיות מינוריות ולכן אין מניעה לאשר בכסף – חלקם אנשים עובדים

רמה 2 היא שונה במהות – לא מאפשרת אוטמטית בחירה בכסף 10 שעות שבועיות חייב לקחת 6 בסל שירותים כולל בן משפחה מטפל (בקורונה מאוד היה חזק) מי שמגדיר את ההתאמה זה חברות הסיעוד. יש לזה יתרונות וחסרונות – נקודת המוצא שלהם זה שבני משפחה הם כן גורם מיטיב וצריך הרבה בקרה של נותן השירותים

כשהן עושות התאמה בודקות קודם אם אין שירותי טרום סיעוד מנותני השירותים – מכניסים מטפלת עוד לפני חוק סיעוד – הרבה פעמים כבר מקבלים שירות ממטפלת ואז מסדירים את זה רשמית דרך החוק. היא כן תציע לו שירותים אחרים ובביוקר זה יעלה יותר אם היא מזהה צרכים של הפגת בדידות. האחריות שלה כשהיא חותמת על גמלה בכסף היא אומרת לו אני שמחרת אותך מהאחריות שלה והיא יודעת שהיא לא בטוח תגיע אליו שוב אז היא לא עושה את זה בקלות דעת.

חשוב לה שייקח שירות – פחות אכפת לה אם מטפלת או קהילה תוכמת ותעדיף הרבה פעמים חברת סיעוד כי פעם בחודשיים יש לה איש מקצוע שרואה את האדם ויכול לאתר חריגות ולתת לה דוח סוציאלי.

מטפלת קבועה בבית יש ערך מוסף בין מטפל לבין זכאי – נוצרים קשרים חשובים מאוד. גם מאפשר יציאה מהבית עם המטפלת ותוציא אותה לקניות ופה זה החשיבות של דחיקת תלות.

ההזדקנות היום היא עד גיל 100 ואנחנו רוצים הזדקנות מיטבית ולכן צריך לצאת מהבית.

היא תמיד תעדיף שירותים

מה שחסר – הפגת בדידות, פורומים, מפגשים, יותר הדרכה וכלים לבני משפחה מטפלים, שירות משולב לזכאי ובן משפחה זוג של קבוצת תמיכה משותפת ולמידה משותפת.

בדרכי רמת 1+2 די זהים ההבדלים יכולים לנבוע בגלל תוספת בודד ולא בהכרח בגלל מצב תפקודי, בודד לא אומר עירי אלא שגר בבית לבד, צריך להבחין אם יש עורך משפחתי או לא. זה לא אידיאלי ש1+2 גרים לבד אבל זה בסדר הם רובם יודעים לנהל אורח חיים עצמאיים. ברמה 2 כשהוא לא בודד – אם זה נקבע על צורך בהשגחה חלקית על צרכים קוגניטיביים נשפיים פסיכאטריים – שם חייבים לתת ליווי מתאים על אחת כמה וכמה אם זה בן משפחה מטפלת ולא מומלץ לשחרר אותם בגמלה בכסף אולי אפילו ממש להגביל.

נמצאים בקשר ישיר וקבוע עם המשח יושבים אפילו באותו בניין, יש להם פורומים משותפים מכירים את כל העוסיות כולל עוסיות לחוק ששם יותר קל להעביר מידע באופן שוטף. קשר ממש ישיר, עושות ביקורי בית משותפים בכל מקרה שעולה מקרה חריג ונותני הישרותים מדווחים לרווחה ועושים ביחד את הביקורים שתפ הדוק

קופח מכירים את העוסיות בכל קופח בעיר כל אחת בקשר עם העוס ברובע שלה – הן מקבלות הפניות מהקופח ויש ערוץ תקשורת ישיר.

המערכת שלה יכולה להוציא נתונים ופילוחים מעניינים על הזכאים לסיעוד ויכולים להעזר ברווחה לפילוחים נוספים יש לה מידע ממש מפורט – הלוואי שיכלה למצוא יותר זמן לשתפים עם עוד גורמים בהקילה – להגיע לכל מרכזי היום וכל חברות הסיעוד עושים ביקורים תקופתיים ופורומים משותפים שומרים על הגחלת ויחסי עבודה תקינים אבל יכל להיות פה הרבה יותר אם כולם ישלבו זרועות יחד ויעבדו יחד לאותה מטרה ושלא כל גורם ימשוך לכיוון שלו.

צריך להחזיק את זה שכל כמה חודשים צריך לעשות שינויים בתכנית בגלל שינוי צרכים. המלחמה הוסיפה עוד הרבה צרכים והתדרדרות במצב.

דחיקת תלות – יש סיבות אובייקטיביות כמו מחלות ששום תכנית טיפול לא תמנע שחיקת תלות, אבל אם הן מזהות יכולות של אדם ב2 להתנהל דרך מטפלת או מרכז יום ולשמר יכולות קוגניטיביים, אוריינות דיגיטלית זהמשמעותי מאוד לדחיקת תלות! פעולות שימור זו השאיפה – הדיוק של הדבר הזה נורא תלוי זכאי וממש מחייבת דיוק. אבל גם צריך לשים על השולחן את זה שאנשים צריכים כסף יותר מהכל!! וחשוב לאפשר שמירת איכות חיים בכסף וייקח פיזיותרפיה או מונית או הוצאות על תרופות וניקיון, וזה ישרת אותו. (מחשבה שלי החזר על קבלות) תמיד תעדיף לשמוע את הזכאי לפני כולם, תמיד לתת להם כבוד להשמיע את מה שהוא רוצה. אין לה יכולת פיקוח ובקרה על מה עושים עם הכסף בפועל. אין דוח הוצאות למרות שזו השיחה שהתנהלה. כן תזהה אם מבוטח קיבל כסף ויקבלו עדכון על הזנחה ויכולה להתנות את הכסף שכזה ישרת את איכות החיים בבית, יערבו בן משפחה, המטרה שהכסף שירת את המבוטח – איך זה היא לא נכנסת לפרטי פרטים

חוק הסיעוד מחייב מבחן הכנסות – חשופים לכל נושא ההכנסות של המבוטח ובן הזוג בבית רואים הכנסות שוטפות רואים אם יש כבר השלמת הכנסה ואם אין וזיהו שאין הכנסות יעפלו למיצוי זכויות בהקשר הזה. אנשים שאומרים שצריכים את הכסף למחייה – צריך לזכור שהמחייה שלהם זה תרופות, קנאביס, זריקות סכרת – המחייה שלהם זה איכות חיים בסיסית ברמת תרופות ורופאים פרטיים. זה אנשים צלולים ומתפקדים שמצליחים לייצר שגרת חיים – אם הכסף הזה מסייע לו לשמר איכות חיים נגיד לקנות ויטמינים ולשפר איכות חיים למה שניקח את זה מהם? גם בזה יש אלמנטים של דחיקת תלות רק מסוג שונה –

דעתה האישית: חוק הסיעוד זה החוק הכי מיוחד בבטל לא כי הוא היחיד שלא מדבר במלואו כסף, ולא נחשב כקצבה אלא גמלה – שמשהמעות שלה היא מעורבות טיפול אישי או טיפול בקהילה, זה גיל שלישי גיל מאוד מורכב, הרבה אגו וכבוד שהם צריכים להכיר בעצמם כבעלי מוגבלות או חולים והם יעשו הכל בגמלת הסיעוד לשמר יכולות ולהשאיר אתם עצמאיים משפיעים פעילים, עצמאיים ככל שאפשר – אין מניעה להמשיך לעבוד רק לא כמטפל, מעודדים התפתחויות אישיות וחברתיות ושמירה על קשרים חברתיים. נושא הגמלות בכסף עדין ורגיש וצריך להיבחן במשורה וצריך כל מי שנותן לו גמלה בכסף לעשות בכבוד ראש.

ראיונות רשויות מקומיות מחקר השטח

מראיית 1

רשות מספר 1:

- יש שני שירותים, "בית חם" ו"קהילה תומכת", כשבית חם עובד ממש טוב והם פותחים עוד ועוד והשני ממש לא עובד. ההבדל הוא באמונה של הצוות במקום. שבקהילה תומכת שזה לא עובד זה עמותה עירונית שמפעילה את השירות ולכן למרות שלא מרוצים ממנה כבר הרבה זמן לא ממש מנתקים איתה את קשרי העבודה ולא מעבירים את הניהול למישהו אחר. ניהול ישיר לא בא בחשבון כי צריך כוח אדם ופיקוח וכדומה. בכל מקרה החברה הזאת מרגישה שזה לא רווחי להכי הם מקבלים 157 שח לראש אבל טוענים שמוציאים הרבה יותר. המרואיינת מדברת על היתרון לגודל ושכשיבואו יותר זה יסתדר אבל בנתיים קשה למכור לציבור שירות שלא ממש קיים.
- יש מחסור בכוח אדם בכללי. התקנים מלאים כביכול אבל כל עובד בלשכה בחצי משרה אחריא על יותר מדי מבוגרים (120 נראה לי?)
- אין איך לפתור את הסוגיה של מרותקי בית (לא בטוחה שזה בסקופ שלנו.. האם ייתכן שנכנסים בקטגוריות 1-2?)
- חסרים תקציבים. יש תוכניות אסטרטגיות אבל בגלל שלא ממשים את המאצ'ינג התקציבי אי אפשר להוציא אותן לפועל.

רשות מספר 2

- בעיה מרכזית היא שאין מבנים בהם אפשר לפתוח מסגרות לפנסיונרים הצעירים יחסית. מסגרות כאלה היו יכולות למנוע התדרדרות של הפנסיונרים למצבי סיעוד. אלו אזרחים שלא מוכרים לשירותי הרווחה והם מחפשים מענה חברתי.
- יש שינוי קל לטובה בשיתוף הפעולה של החברה הערבית. **עשו את זה באמצעות קבוצות נושאיות.** גם בקהילה תומכת יש עליה חדה בהשתתפות של החברה הערבית.
- קהילה תומכת- לא קל להרים את זה. חושבת לספק את השירותים באמצעות אזרחים וותיקים שהיו בעלי מקצוע. החברה שמפעילה אתזה היא "תגבור" שהמנהלת שלה היא עובדת סוציאלית, יש קשר טוב מאוד איתם. נפתח מועדון של חברי קהילה תומכת שמצטרפים אליו גם אנשים שאינם חלק מקהילה תומכת. מאוד מרוצים מזה, מאפשר בקרה על אנשים בודדים. **המשרד מוזיל את המחיר עבור האזרחים הותיקים וזה מקל.** המש"ח משווק את זה לציבור וגם המפעיל עצמו משווק.
- פתחו שירות של ייעוץ לאזרח הוותיק על כל מה שיש בעיר ומגיע לו. מנגיש את המידע על התוכניות. המרואיינת עושה את זה כי הידע אצלה, זה מקל על עו"ס. היא יושבת במרכז עוצמה והם מגיעים לפגישה פרטנית ויש שם אנשי מקצוע (למשל חברת חשמל וכו) וככה אפשר לפתור את הכל במקום. **זה גם מוריד את הסטיגמה מללכת לרווחה.** היא תבין אם בכלל יש צורך לפתוח תיק ברווחה ומקלידה את האינטק הראשוני וגם זה מקל על העו"ס הפרטני.
- מי שרגיל לחיות עם קצבאות ירצה את הכסף, ולא ייקח שירותים במקום. יש גם בעייתיות עם בן המשפחה המטפל.
- **מסגרות עולות יותר מדי, נותנת כדוגמא את מרכזי היום.**

- קהילה תומכת נותנת מענה מובנה וממוקד: חיישן מצוקה, אמבולנס וכו... זה לא מחליף מענה סיעודי במהות שלו.
- **בני המשפחה הם בעלי השפעה מכרעת על השירותים שהקשיש לוקח.** אם בני המשפחה המטפלים מעודדים מסגרות אז יותר סיכוי שהקשיש ילך.
- באידיאל שלה: תפריט המחולק לפי צרכים שבא אוטומטי עם הגיל ולא צריך להוכיח זכאות לכל מיני דברים.
- לא חסר לה כרשות מקומית כלום. כל מה שהיא דורשת מקבלת.
- גברים פחות יוצאים למועדונים ומפגשים חברתיים מנשים. פותחת מועדון גברים, בהתבסס על קבוצת מתפללים. להלביש את הרווחה עליהם בבית כנסת מעבר לתוכן התורני. נותנת את זה ללא עלות.

רשות מספר 3

- אזרחים ותיקים- 20% מכלל התושבים. צוות של 11 עובדים שנותרים מענה של יחידת התעללות והזנחה, בני משפחה מטפלים, תיאום טיפולים רפואיים, ניצולי שואה, תחום דיגיטציה, מוקד שייכות שמתעסק בעירייה ורכזת שייכות אחראית על הפעילויות הקהילתיות.
- **כל הפעילויות החיצוניות מתופעלות ע"י העמותה למען הקשיש.** יש 256 בתי אב בקהילה תומכת, 60 אזרחים ותיקים במרכז יום חלקם רווחה וחלקם חוק סיעוד, מועדון מופת 35 השמות, מועדון מועשר 35 אזרחים ותיקים, ועוד מועדונים חברתיים עם בסך הכל קרוב ל400 קשישים. בחוגים משתתפים בכמות גבוהה במבנה של המרכז יום. במקביל יש 80-90 חברים במועדון חברתי ועוד ועוד. **נשמע שיש היענות. כן לא ממצה את הפוטנציאל – אם היו עוד תקציבים וכוח אדם היה אפשר להגיע לעוד ועוד קשישים.**
- היו רוצים לתת עוד חוגים, למשל הקתדרה הלימודית. לפעול יותר עם אזרחים ותיקים צעירים כדי לעשות עבודת מניעה, לתת כלים של דיגיטציה לשיפור המשך החיים שלהם. גם מרכז היום הוא נורא קטן. חסרים בפועל חדרים ומבנים. הם בפרוייקט של תקציב גמיש של משרד הרווחה והם השתמשו בזה לכל מיני פעילויות גם לכל מחוז הצפון אפילו להט"ב זהב!!!
- קהילה תומכת- חברי הקהילה מרוצים. בשנים הראשונות הוציאו המון טיולים יומיים עם ארוחה וכו אבל כי היו תקציבים. גובים 25 שח מקשיש חוץ מאלו של ביטוח לאומי. משתמשים בזה למגוון שימושים, למשל מוניות מספרה פדיקור וכו. אין עודפים כדי להוציא על עוד פעילויות. כן עושים הרבה הפגת בדידות. הם משתתפים גם במועדונים החברתיים ויש להם הנחה שם.
- פערים חוץ מתקציב וכו אדם- יש פער עם ביטוח לאומי. **ברגע שאפשר לקחת גמלה בכסף/בן משפחה שיטפל צריך לעבוד קשה כדי לגרום לקשיש להוציא כסף על הפעילויות ולא לקבל כסף בסיס.** להגביר פיקוח על בני משפחה. כשהחברות סיעוד מפקחות זה לוקח עמלה מסויימת מהכסף של המשפחה. **שירות של אוכל בבתים היה יכול לגרום לאנשים לא לקחת כסף אלא שירות. הצעה: צריך לחלק את התקציב לשליש בריאות שלישי רווחה שלישי כללי, ולהכריח את הקשיש להשתמש בכסף ליעודו. במקביל להרחיב את סל השירותים שמציעים לקשיש כדי שהוא יוכל לבחור מה שנותרים בשליש של הרווחה. ליווי אישי לבדיקות, חוגים, הפגת בדידות....**
- הורידו את התעריפים אבל המחירים עלו וזה בעיה.
- **המרכז יום תלוי בבטל"א ולא בחוק רווחה.** אם מישהו לא הלך כמה ימים למרכז יום הכסף מוזן לקשישים לחשבון וזה עוד תמריץ שלילי.
- אם יפתחו עוד מסגרות זה אומר לפגוע במרכז יום שהוא עמוד השדרה של השירותים שלהם וזה לא משהו שהם רוצים לעשות.
- יש ניתוק ממשרד הרווחה- גם תקציבית עם המאצי'נג שמשרד הרווחה לא משפה כמו שצריך. הם גם לא מחזירים כסף שפוספס במאצי'נג. כל פרוייקט חדש הם אומרים לרשות

- לקחת מסל גמיש או להוריד מושמים מהמרכז יום. מערכת היחסים עם משרד הרווחה
- דורשת לשקר, מרגיש שנלחמים במשרד ושהמשרד לא פרטנר. אפילו מה שמשלמים
- לעמותה בהשתתפות עצמית לא נשאר אצל האזרחים הותיקים אלא הולך לתקציב
- העירייה הכללי. תלוי בראש העיר להעביר את זה לשירותים לאזרחים ותיקים
- הכל מועבר דרך העמותה למען הקשיש והם הספק להכל. זה הרבה יותר נוח.
- איך עושים ריצ'ינג אווט לאזרחים הוותיקים? השירות הטוב והאמין שמביא קליינטים.
- שיתופי הפעולה של העמותה עם הלשכה בעירייה מביאה המון תרומה. בנוסף פרסומים
- באתרים ובפייסבוק, פלאיירים וכו'. בנוסף יש גם תיאום טיפול- תוכנית שבמסגרתה קופ"ח
- נותנת רשימת הפניות של אזרחים ותיקים וככה אפשר לתת להם מענים מותאמים.
- עוד משהו שמושך: שירותים שלא מקושרים לרווחה או לקשישים – מיתוג אחר. מרכז
- יום קיבל שם אחרי כחלק מהמיתוג.
- שירות שחשוב לאנשים גם מושך אותם- למשל פיזיותרפיה.
- שיתופי הפעולה החזקים יוצרים תפקוד מעולה. גם שיתופי פעולה עם גופים אחרים כמו גנים
- ומשטרה ומכבי אש.

רשות מספר 4

- 6 מועדוני קשישים: שני מועדוני מופת (3 ימים כולל הסעות 21 ארוחות. השתתפות עצמית),
- 3 חברתיים (מעט תקציב, קצת חוגים ולפעמים טיול) ואחד מועשר (3 פעמים ארוחת בוקר
- והסעה. השתתפות עצמית) רוב המגיעים הם נשים, 275 נשים ביחס 15 גברים. יש
- ביקוש גבוה למועדונים, ממלאים יותר מהמכסות כלומר מקבלים תקציב רק לחלק
- מהמבקרים. אבל לא מסרבים למי שצמא כל כך לשירותים ולא רוצה להישאר בבית...
- חסרים תקציבים וגם המקום קטן יחסית ולא יכול להכיל את כולם.
- קושי להביא גברים, חוג ספורט ואוריינות דיגיטלית כן משכו את הגברים. יש עמותה
- לפנסיונרים משכילים ששם כן יש יותר גברים מנשים... יחסית מכל הגילאים גיל השלישי
- מגיעות למועדונים. גם מבחינה תפקודית יש גיוון יחסי.
- יש תוכניות של הפגת בדידות בקרב מרותקי בית בעזרת מתנדבים ומלגאים, הייתה תוכנית
- של הנכדים עם הסבתות דרך התיכון בערערה. יש חוגים כמו חוגי התעמלות שהם לכלל
- האזרחים הותיקים, תוכנית מתחברים בתוכה אזרחים ותיקים גם נותנים ומתנדבים ולא רק
- צרכנים אז היו שתי קבוצות של 15 מפגשים לחיזוק היכולת להתנדב ולתרום. קורסים מאוד
- מוצלחים והאנשים עדיין מתנדבי בקהילה.
- הייתה רוצה לתת יותר שירותים לאוכלוסייה שנמצאת בבית ולא יכולים לצאת. חסר לכך
- תקציב.
- הביקור במועדונים לא פוגע בגמלת סיעוד בכלל. לא מספקים בכלל שירותים שדורשים
- השתתפות עצמית של הצרכנים מתוך גמלת הסיעוד, כי הם מבינים שהמצב הסוציאלקונומי
- של התושבים בכפר נמוך והם לא ישתתפו. בשירותים בהשתתפות עצמית יש עמותה
- משלמת עבור הרבה מהמשתתפות אחוזים גבוהים מסובסדים על ידי עמותות.
- אולי הדור הבא כן ידאג לעצמו יותר ולא יעביר את הקצבאות לבני המשפחה
- הקורונה עשתה טוב לשירותים לקשישים! הקשישים היו הכי מסכנים בקורונה ומאז שמים
- על זה דגש, זה עלה למודעות ואנשים כבר לא אוהבים להישאר בבית. בנוסף גם מתקצבים
- יותר

רשות מספר 5

- מרגע שמביאים אותם החוצה הם נשארים בחוץ בפעילות החברתית קהילתית. זה דוחק את
- התלות, מגביל הדרדרות
- היו תקועים 17 שנים על שתי קהילות תומכות לא מלאות. החליפו ספק לפני 6 שנים והיום
- יש שתי קהילות כמעט מלאות. יש קהילות שמרניות גדולות כמו חרדים אתיפים וכו' שהן לא
- צורכות כיום שירותי רווחה.

- יוניפר זה נחמד אבל עומדים על פחות מ80 איש. יכול להיות עוד שירותים בסגנון.
- חסרים תקציבים, המודל התקציבי לא גמיש מספיק.
- פרוייקט של מניעת נפילות זה דבר שכדאי להשקיע בו. פתרונות טכנולוגיים לשימוש הגיל השלישי.
- הם לא מצליחים לנצל את התקציב ומחזיר למשרד הרווחה המון כסף- זה גמיש כביכול אבל יש חסמים ארגוניים שמונעים מהם לממש דברים שהם מגישים. רואה בזה תקופת מעבר כך שאנשי התקציבים עוד לא עברו למוד הגמיש של אנשי השרותים והאסטרטגיה

רשות מספר 6:

- עמותה מפעילה חלק מהשירותים, מועצה אזורית עם מושבים, קיבוצים.
- לכל ישוב יש עובדת סוציאלית שנותנת שירותים לכל האוכלוסיות כולל הוותיקים, מודל מרחבי. כל מה שקורה בישוב היא אחראית עליו, אבל יש גם מומחיות לכל עובדת סוציאלית שיכולה לייעץ לחברותיה במומחיות שלה בנוגע לישוב שלה. יש גם מישהו מטעם הישובים והם עובדים צמוד עם המש"ח.
- היחידה למניעת התעללות, מוגנות האזרח הותיק
- קהילה תומכת, מועדון מופת, מועדונים בישובים, מועדון מועשר. בכל ישוב כמעט יש מועדון חברתי. יש בתים חמים. יש פעילות של עמותת גילאור- חוגים, העשרה.
- הייחודיות של המועצה היא היכרות קרובה עם האוכלוסיה. יש שיתופי פעולה קרובים עם בעלי התפקידים הרלוונטים בישובים
- בני משפחה מטפלים- עושים סדנאות בתחום לבני משפחה.
- קהילה תומכת עובדת טוב מאוד, מונה כמעט את כל מי שבמכסה ועובדים על פתיחת קהילה נוספת. יש אבות בית מצוינים וזה עושה את ההבדל. רוב הפעילויות הן פר ישוב כי זה זוכה למענה יותר. אתגר חדש בזה- סל גמיש. בעייתי כי זה נוגס בכסף שהם יכולים לשלם לקהילה תומכת, וגם כי אין להם קאנטרי או תיאטרון וכו כלומר אין להם מה לספק. זה בעייתי במועצה אזורית. חוץ מזה זה בעייתי כי זה בהכרח מפחית את התקציב הרפואי שלהם. אם היה יותר תקציב אולי היה עובד.
- כמעט כולם לוקחים גם כסף ושמים בכיס/נותנים משפחה. גם המטפלות שלוקחים בכסף הזה לא מספקות את השירות שאפשר לספק בכסף הזה בשירותים בקהילה.
- במרכז יום אפשר לשלם בשעות סיעוד, אבל אין מרכזי יום במועצה ואין תקצוב להסעות למרכזי יום אחרים. הייתה רוצה שיתקצבו להם הסעות למרכזי יום. במזל במועדונים קולטים גם סיעודיים יותר אבל זה בגלל אופי הקהילות.
- היו רוצים עוד מועדוני מופת, אבל זה בא על אותה עוגה של סל גמיש.
- לא חושבת שיש שירותים שאפשר לספק ויגרום לאנשים לא לקחת כסף אלא שירותים.
- יש מרפאות כללית בישובים ויש שיתוף פעולה עם העובדים הסוציאליים אבל הן קטנות אז כשיש חוסר זה מורגש מאוד.
- חוסר התחבורה הציבורית גם משפיע על היכולת לצרוך שירותים במקומות אחרים.
- מודל הפעלה עם העמותה- העמותה היא הגורם המפעיל אבל יש שיתופי פעולה מאוד מאוד קרובים, זה ממש חלק מהמועצה.
- הייתה שמחה לקאנטרי ומבני תרבות שיאפשרו שירותים מגוונים לקהילה. גם התחום הטיפולי לוקה בחסר.

רשות מספר 7

- המודל המרחבי עובד גם כאן, יש עו"ס לכל ישוב. בנוסף מרכזת את היחידה לרווחת האזרחים הותיקים ואת הפעילויות הציבוריות לותיקים.
- העמודה למען הותיק מאוד חזקה, פועלת רק במועצה ובשיתוף פעולה הדוק עם המועצה. מוציאה לפועל הרבה מהדברים. למשל שתי קהילות תומכות, מרכז יום, ותיקים מאמצים ותיקים בודדים, פרוייקט תעסוקה ביתית למרותקים פיזית או מבחירה.

- יש מועדון חברתי אחד או יותר בכל ישוב אותם מפעילים מתנדבים שהמועצה מכשירה ומעשירה, 3 מועדוני מופת ומועשר, היחידה לשלום הוטיק..
- מאוד מרוצים מהקהילה התומכת, העמותה מוציאה את זה לפועל טוב. הצטרפו לפני שנה לסל הגמיש והם כל הזמן מוסיפים לשם תכנים- חוגי ספורט, מנוי לקאנטרי, טיולים כל חודש, תגבורים לאב הבית... האזרחים הוטיקים מאוד מרוצים ולא מתנתקים אפילו בזמן הפינוי במלחמה! יש בעיה בגיוס, הרבה פעמים כי זה דורש יציאה מהקיבוצים לפעמים וזה לא מעניין אותם.
- מאז הקורונה מאוד קשה לגרום לאנשים לצאת מהבית, בעיה לא רק של הוטיקים. יש גם מגבלה תקציבית קשה ומגבלת כוח אדם- אין עובדים שמוקצים לתחום האזרחים הוטיקים חוץ מתום עצמה. לא הייתה משנה כלום מהשירותים רק מרחיבה. מתכננת להגיע לקתדרה (וטיקים צעירים) פעם בשבוע כדי למשוך רעוד פעילויות.
- חוק סיעוד: לא חושבת שיש איך לגרום לאנשים לא לקחת כסף אם הם במצב סוציאקונומי נמוך. במצב סוציאקונומי גבוה צריך להתאים שירותים ברמה
- בעיה חמורה- התקציב הגמיש. הכספים צבועים במילא ואין עם מה לעבוד באמת. זה לא באמת גמיש.
- חסר גם הכשרות מקצועיות ממוקדות, כלים פרקטיים.
- התמודדות של העמותה הוא עניין ההסעות- הכל רחוק וגם פקוק. לפעמים אנשים נמצאים שעה וחצי בהסעה וזה גורם להם לא להגיע.
- משתפים פעולה עם משרד הבריאות ולשכת הבריאות בעכו
- מקנאה בערים שיש להם מחלקת אזרחים וטיקים שמתמחה ומתמקדת באוכלוסייה הזאת.

רשות מספר 8

- K51 תושבים מתוכם K9 אזרחים וטיקים-המון. יש הזדקנות של העיר, סוציאקונומי 8 ומחירי דירות גבוהים.
- עמותה מקומית לרווחת האזרח הוטיק שנתמכת ע"י העירייה,
- מפעילים רצף של שירותים: לעצמיים יש מועדונים שכונתיים, 3 כאלה בהם יש רק נשים!! חוץ מלפעילויות ספציפיות, (באידיאל שלה יש בכל שכונה, אפילו מופעלים ע"י הקליינטים), שגם בזמן הקורונה מאוד היה טוב ומסגרת שהחזיקה אותם. בהמשך הרצף יש מרכז יום עם הסעות כולל אגף לתשושים, יש גידול באוכלוסייה שם ויש הרבה פעילויות וחוגים שם (ספורט תופס חזק מאוד). בקצה יש שירותים לקשישים מרותקי בית כולל מתנדבים, מעט מאמנות ספורט.
- יש 200 איש ב2 קהילות תומכות, לא מלאות לגמרי. **שירות מצוין שנותן להגיע להרבה אנשים בזכות הלחצן מצוקה.** הן מופעלות באמצעות העמותה המקומית שמפעילה גם את המרכז יום ויש רציפות תפעולית גם יחד עם המש"ח, וככה לא מפספסים אף אחד ואת הצרכים של אף אחד. ייתרון בעיר קטנה עם עמותה מקומית. צריך לייצר דרך הקהילות התומכות קהילות על אמת- לחבר קבוצות בתוך הקהילות, רזולוציה פנימית.
- מה שיגרום לאנשים לא לקחת כסף זה לא לשאול אותם על זה קודם כל ולפני הכל.
- צריך להגיע הביתה, לספק ספורט והתעמלות לבתים, להביא את העולם החיצוני לתוך הבית.
- נושא השיקום לוקה בחסר, אם היה אפשר לייצר סניף שיקומי במרכזי היום זה היה מושך אנשים ונותן מענה רלוונטי וגם כבר מביא אותם החוצה לשירות.
- חסרים מועדונים חברתיים איכותיים ומובנים, אין מספיק כוח אדם שיכול גם להרים משהו מקצועי וגם לספק יחס אישי. חסרה גם הכשרה דיגיטלית.
- מיצוי זכויות- מתנדבים שמגיעים עד הבית.
- באופן כללי יש הרבה פרויקטים שמתבססים על מתנדבים.
- קושי מרכזי- אסדרה: **אין הגדרות למספר של גימלאים למועדון/לרצות, יחד עם זה יגיע תקצוב והגדרות כוח אדם.** מה המשרד מצפה? נגישות? היא רוצה סל גמיש שיאפשר תוכניות שונות בין המועדונים אבל לא סל גמיש שלא מגדיר כלום. יש גמישות איפה שלא צריך ולהיפך.

- הפעלה עצמית של האזרחים הותיקים או מסלולי תעסוקה אחרים.
- לעזור לאנשים להשיג את מה שמגיע להם, טיפולים, וכו'.

מראיית 2

רשות מספר 1

הבעיה המרכזית היא שאין לנו מבנים. בעיה זו מגבילה אותנו בפתיחת תכניות בקהילה לפנסיונרים צעירים. תכניות כאלו יכולים למנוע הדרדרות בקרב אזרחים ותיקים צעירים.

קיבלנו תקציב מיוחד לערים מעורבות, ממשרד נגב גליל. היינו מופתעים כמה האזרחים משתפים פעולה. האזרחים מוכנים להשתתף בסכום סמלי. אנחנו רואים שינוי בחברה הערבית שיותר משתפת פעולה, אנחנו מצליחים לפתוח להם מועדונים המותאמים להם. בקהילות תומכות, התחלנו עם 3 אזרחים ותיקים מהחברה הערבית, היום שותפים יותר מ-30 אזרחים ותיקים.

אנחנו עדיין לומדים את החומר של הסל הגמיש. לא קל למצוא ספקים שיספקו את השירותים בקהילה. חשבנו על אופציה שאזרחים ותיקים הם אלו שיהיו ספקים נותני שירות לאזרחים ותיקים אחרים. בתקופת הקורונה והמלחמה, אזרחים ותיקים נרתמו להתנדב למען אזרחים ותיקים אחרים. פרויקט היה מאוד מוצלח ומועיל.

יש חברה שמפעילה את הקהילות התומכות שהמנהלת שלה היא עובדת סוציאלית, יש לנו קשר מאוד טוב איתם. האזרחים הותיקים מאוד מרוצים. המשרד מוזיל את העלויות, מקל מאוד לאזרחים הותיקים ומאפשר להם להשתתף בתכניות השונות. הספק והמש"ח משווקים את הקהילה התומכת.

עוד צורך שעולה מהשטח- אנשים שמגיעים לגיל פרישה רוצים לשמוע מהם הזכויות שלהם. התחלנו להציע שירותי ייעוץ הנותנים מידע לאזרח הותיק את הזכויות שלו. אני מרכזת את כל תחום לאזרח ותיק, לכן הידע נמצא אצלי ולכן אני מציעה את השירות הזה ופוגשת את האזרחים הותיקים פגישות פרטניות. זה מקל על העו"ס. מרכז עוצמה- מרכז למיצוי זכויות, שם אני יושבת ומייעצת לאזרח הותיק. במרכז הזה נמצאים אנשי מקצוע אחרים, כמו חברת חשמל, זה מאוד פרקטי ונוח. הפגישות האלו יותר מוגשות לאזרח. הוא יעדיף להגיע אלינו מאשר ללכת לפתוח תיק ברווחה (סטיגמה שלילית). בפועל, לאחר הפגישה עם האזרח הותיק, היא יודעת אם להפנות אותו לעו"ס במידת הצורך. לא מגיעים הרבה אנשים, צריך עוד לשווק את זה. מפה לאוזן, ככה אני מאמינה.

מי שרגיל לחיות עם קצבאות ירצה את הכסף, ולא ייקח שירותים במקום.

בעיה מרכזית היא שהרבה אזרחים ותיקים מקבלים את גמלת הסיעוד וזה מגיע לבני המשפחה. המשפחה היא המטפלת והגמלה מגיעה אליהם.

הבעיה היא שהמסגרות האלו מאוד יקרות ולא שוות לאזרח הוותיק. הוא לא ירצה לוותר על הרבה שעות סיעוד לטובת מרכז יום. הוא יעדיף שעות סיעוד מאשר שעות למרכז יום. אם משרד הרווחה יצמצם את השעות של מרכזי היום על חשבון הסיעוד, אז הם ירצו להגיע למרכזי היום. המחיר לא מצדיק את השירות. לתת יותר תקצוב, האדם ישלם פחות כסף. הדור שמזדקן היום הוא דור יותר אינטלגנט ועצמאי, וצריך להציע להם מתווה שיתאים להם.

קהילה התומכת נותנת שירות יותר מובנה. זה לא מחליף את שירותי סיעוד. צריך להיות שירות המשלים את שירותי הסיעוד.

בני המשפחה הם מאוד משמעותיים בקבלת ההחלטות. הם צריכים להיות שותפים ולהאמין בשירותים המוצעים.

צריך להציע תפריט שהוא מחולק לפי צרכים, שאותו האזרח הותיק מקבל אוטומטית ברגע שהוא מגיע לגיל פרישה. כך הוא יכול לקבל בצורה אוטומטית זכאות לחוק הסיעוד.

לאחרונה נתקלתי שגברים פחות יוצאים למועדונים ולמפגשים חברתיים מנשים. אנחנו נמצאים בתהליך פתיחה של מועדון לגברים. הגענו לקבוצה של גברים מתפללים, ואנחנו מלבישים על הקבוצה שירותים בקהילה. הצלחנו להעניק להם הרצאות ללא עלות. יש הרבה שירותים בחינם, צריך פשוט להכיר אותם.

הקושי הוא שאין הכשרה לעו"ס על החלק הקהילתי. אני למדתי מהשטח ומקולגים. יש לנו גם בעיה של כוח אדם, אין לנו מספיק עובדים.

המכרזים קשים ולא מונגשים. הכתיבת שלהם לוקחת מאתנו המון זמן על חשבון דברים אחרים.

רשות מספר 2

קהילה תומכת

60 אזרחים ותיקים במרכז היום- חלקם חוק סיעוד וחלקם רווחה

מועדון מופת 65 משתתפים

6 מועדונים- 400 קשישים

מלבד מרכז יום אחד, יש לנו חוגים במרכז יום שמגיעים הרבה אנשים, בניהם אזרחים ותיקים צעירים.

מועדונים החברתיים בשכונות- אחד לדוברי רוסית ואחד לדוברי עברית- כל אחד מותאם לאוכלוסייה

זה לא ממצה את הפוטנציאל- אם היה לנו כוח אדם ותקציבים- היינו רוצים להרחיב ולתת יותר

הייתי רוצה לתת יותר חוגים, לפנות לאזרחים הותיקים צעירים, עבודת מניעה של בדידות, להזדקנות מיטבית. לעלות את רמת הדיגיטציה. מרכז יום הוא נורא קטן, אין מספיק תפוסה. אין מספיק חדרים. חדר אוכל משמש לכמה פעילויות, בנוסף לארוחות.

בעיה של מבנים ושל תקציב.

עם התקציב הגמיש יכלנו לפתוח שלוש תכניות חדשות. עדיין חסר לנו משאבים בתקציב ובכוח אדם

קהילות תומכות- האזרחים הותיקים מרוצים. בשנים הראשונות היינו מוציאים הרבה טיולים יומיים. כיום העלויות עולות, והתקציב לא השתנה. אין פה עודף תקציב שאיתו יכלנו להציע יותר שירותים.

אב קהילה יצר קשר עם אומנים ומארגנים הופעות לקשישים המרותקים, ליד המיטה שלהם. הקהילה תומכת משיגה תווים לקראת החגים. הם משתתפים לפעילויות החברתיות, הם מקבלים הנחה בתוך המועדונים.

ביטוח לאומי הוא אחד הנקודות המורכבות שלנו. גמלת הסיעוד שאזרחים ותיקים מקבלים, הוא בעייתי. הילדים משתשמים בר כסף, האזרח הותיק לא נהנה ממנו. לאפשר לבני המשפחה להירשם לחברת סיעוד הוא פתרון, בגלל העדר כוח אדם.

הקטע של הכסף היה בהתחלה מאוד הגיוני. בפועל הכסף לא הלך למטרה. ביטוח לאומי- אם היה שירות שמעניק ארוחות חמות, האזרחים הותיקים היו לוקחים את השירות הזה.

לחלק את גמלת הסעוד:

שליש- שירותי בריאות

שליש- שירותי רווחה

שליש- שירותים קהילתיים

אדם שלא משתמש בשליש של רווחה הוא יפסיד אותו. זה יחייב אותם להשתמד בשירותים מאותו סוג.

שירותים חסרים: ליווי אישי לקופת חולים, שימוש בגמלת סיועד לחוגים. יש לנו שירותים קיימים. צריך לאפשר להשתמש בגמלת סיועד לשירותים מהסוג הזה.

לגבי מרכזי היום, משרד הרווחה הפך לתקצוב חודשי, ביטוח לאומי לא נכנס לזה. זה מאוד בעייתי בתקופות שהרבה נשארים בבתי. מרכז היום ברובו מבוסס על אזרחים מגמלת הסיועד. תעריף יומי נמוך וללא ביטוח להיעדרות. הם מפסידיים כסף.

המוסד לביטוח לאומי החליט שאדם שלא מגיע בתדירות גבוהה, הוא יצטרך לשלם על ימים אלו.

יש ניתוק ממשרד הרווחה, ניתוק כלכלי, תעריפים שפוגעים בתכניות, משרד הרווחה לא משפט כמו שצריך, הרשויות משלמות הרבה יותר. כל פרויקט חדש, הם מצפים שנשתמש בסל גמיש, הם מצפים שנוריד תקציב ממרכזי יום ונופשוניים.

יש ניתוק בדרישות במכרזים.

ההשתתפות העצמית עוברת לחשבון הכללי של העירייה. ראש העיר לוקח את הכסף ומחזיר את הכסף לרווחה. אבל זה לא קורה בכל רשות.

ריצ'ינג אאוט מוצלח יכלול קודם כל שירות טוב ואמין וגם שיתוף פעולה עם משרד הרווחה והמשח משמעותי לעשייה מיטבית פרסום ושיווק על ידי העירייה תיאום טיפול- קופות החולים נותנות לנו הפניות שאנחנו לא מכירים דיגטציה-מיתוג אחר, נורמטיבי ולא שירות רווחה, הרבה מגיעים לשירותים אחרים בזכות השירות הזה חשיבות של המיתוג- מרכז אופק ולא מרכז יום

מרכז היום של העמותה- אנחנו נותנים כל יום 4 שעות במרכזי יום, לעומת הדרישה 5 שעות שבועיות.

הטענה כלפינו - אנחנו לא מייצגים, השיתוף פעולה שלנו הוא ייחודי. בעבודה המקצועית.

יש מקומות שאין בהם שקיפות ושיתוף בין המש"ח לעמותה. סנכרון מלא במצבי חירום. נותנים מענה רחב, לא רק לקשישים, יד שרה, שיתוף פעולה עם בתי ספר, משטרה וצבא.

רשות מספר 3

רקע על המש"ח

6 מועדוני קשישים

2 מועדוני מופת

2 מועדונים חברתיים

רובן נשים, מעט גברים

כל מועדון בעל מודל ייחודי

בעיות תקציביות משמעותיות

במועדוני מופת- יש ביקוש גבוה, האזרחיות הותיקות נהנות מחוגים מגוונים, אך נדרש מהן השתתפות עצמית

יש בעיקר ביקוש לנשים, אנחנו בתפוסה מלאה. יש לנו 35 מכסות, בפועל 45 משתתפות מגיעות. אנחנו לא רוצים לסרב הגעה. אנחנו מנסים לקבל את כל מי שרוצה להגיע. מבחינת חוגים, אנחנו מחלקים את החוגים לשתי נאגלות, לא ייהנו מכל המפגשים, אבל כולם נהנים. ארוחות צהריים, אין ברירה אלא להזמין 35 מנות, יש כאלה שלא אוכלים.

יש השתתפות נמוכה של גברים. צריך להתאים לגברים חוגים מתאימים, כמו התעלמות ודיגיטציה. לטילים- כולם מגיעים

זה לא עניין של סטיגמה שלילית על שירותי רווחה- אם הנשים מגיעות, סימן שזאת לא הבעיה. יש לנו עמותה לפקידים פנסיונרים, שרוב החברים הם גברים. זה רק עניין של התאמת השירותים ושינוי תפיסה.

❖ תכניות בקהילה

1. מרותקות בית- תלמידים מתנדבים מגיעים לבתים שלהן ועושות איתן פעילויות
2. נכדים עם סבתות- ביקורים של נכדים, במסגרת התיכון. פידבקים מאוד טובים
3. קולות קוראים- חוגים לכל האזרחים הותיקים
4. מתחברים- דרך מפעל הפיס. אנחנו הרשות הערבית היחידה ששותפה לפרוייקט הזה. במסגרתו, אזרחים ותיקים מתנדבים, מאוד משמעותי
5. להקה מוזיקלית של אזרחיות ותיקות מתנדבות

אנחנו מאמינים שכאשר אזרחים ותיקים מתנדבים בקהילה, זה נותן להם המון וזה משמעותי מאוד.

❖ מה הפערים? מה החוסרים?

אנחנו רוצים לתת שירותים לכל האזרחים הותיקים בקהילה.

תקציב שנתי לתכניות כמו התכני למרותקות בית או למועדונים חברתיים, זה מאפשר המשכיות של התכניות

יש לנו הרבה מרותקות בית, צריך להתאים להן שירותים מתאימים

אין לנו מרכזי יום. הרמה הסוציאלית מאוד נמוכה, כולם משתמשים בגמלה, הכסף הזה חשוב להם ומגיע לילדים.

מועדון מופת עולה לאזרח הותיק 600 ש"ח בשנה. יש עמותה שמתקצבת 200 ש"ח פר משתתף, כך שהאזרח הותיק משלם רק 400 ש"ח.

העשייה הייתה בתאוצה אחרי הקורונה. החברה הבינה שהאזרחים הותיקים הם קבוצה חלשה שיש לדאוג לה. האזרחים הותיקים בעצמם הבינו את הקושי בבדידות. ליצור אוכלוסיה שיוצרת קהילה, שהם שותפים ומתנדבים בה.

הצעה: לאחד את כל המועדונים למועדון אחד שישרת את כולם. שיהיו אגפים שונים, לפי תפקודים וצרכים שונים. מבנה אחד שייתן א כל המענים. האיחוד הזה יכול להקל עלינו, לרכז כוח אדם, לפתור בעיות לוגיסטיות.

רשות מספר 3

הצעה 1: המשמעויות הן סביב עניין הכסף. יכול להיות שברמת תלות נמוכות, אם היה אפשר להגביל את שעות חוק הסיעוד בבית ולהעביר שעות לשירותים חברתיים אחרים, היינו רואים תוצאות אחרות. יכול להיות שאם ביטוח לאומי, יגביל את שעות הסיעוד בבית, האזרח הותיק יהיה חייב לבחור את סל המענים האחר.

הצעה 2: בטופס שהאזרח הותיק ממלא בביטוח לאומי לקבלת חוק הסיעוד, הטיפול הביתי נמצא בשורה הראשונה, בעוד שמרכזי יום נמצאים בשורות האחרונות. היה ניסיון לבקש מביטוח הלאומי לעלות את מרכזי היום בשורות עליונות בטופס.

הצעה 3: ברגע שאזרחים ותיקים מתחילים לצרוך את השירותים בקהילה, הם ממשיכים לצרוך. הביעה גדולה היא לגרום לאזרחים להתחיל לצרוך את השירותים החברתיים. שימוש ביתרון של סל גמיש- לחזק תכניות קצרות מועד וכך לעודד אותם להצטרף לתכניות מובנות. לאפשר לאזרחים ותיקים שמשתמשים בגמלת סיעוד להשתתף בתכניות בקהילה, וכך הם ימשיכו להגיע.

לדוגמא, אנחנו מפעילים תכניות להפגת בדידות ושייכות: מתנדבים נכנסו לבתים מהקהילה האתיופים וחלקם הצטרפו כבר למעגלים חברתיים בקהילה. במגזר החרדי- לקחנו בנות סמינרים עם מנחה בתחום האומנות, המטרה הייתה שהקשישות החרדיות יצאו מביתן.

חוק סיעוד- הם תחת ביטוח הלאומי. למרות זאת, אפשר לשתף ולצרף אותם לתכניות קיימות וככה הם יצרכו שירותים חברתיים מטעם משרד הרווחה. לטשטש את הגבולות האלה.

היינו תקועים על שתי קהילות לא מלאות במשך 17 שנה, החלפנו ספק לפני 5 שנים, עכשיו יש קהילות שרובן מלאות.

מקבצי דיור הן מסגרות מובנות אבל מגבילות את מספר מקבלי השירות.

יש לנו הרבה קהילות שמרניות שלא צורכות מספיק שירותים- קהילה שמרנית פחות משתפת פעולה עם שירותי פנאי ותרבות. יש פוטנציאל למקד את זה אחרת.

השירותים בקהילה תומכת- רמת צריכת השירותים לא גבוהה, העלויות גבוהות. כשהצריכה נמוכה זה מאפשר לנו לספק את השירותים האלו.

יוניפר- נחמד אבל ההיקף לא גדול.

שנה שעברה, החזרתי מאוד אלפי שקלים, על אי ניצול כספים. המעבר לגמישות תקציבית, עדיין דורש דרישות גבוהות וחסמים ארגוניים. גם משרד הרווחה מול הגורמים הכספיים לא תפור לגמרי.

פרוייקט מניעת נפילות- ערכות מניעת נפילות בבית, חיישנים וכו'. מניעת הנפילה הוא מאוד משמעותי. עזרים טכנולוגיים. צריך גם לחשוב עליהם כחלופה.

מצד אחד השירותים החברתיים נבנו היסטורית בצורה הדרגתית, ללא חשיבה מעוגנת. מצד שני, מוני 100- איך מתכננים עיר לאזרחים ותיקים? פיתוח שירותים בצורה רוחבית עירונית ולא בראיית סילו.

מראיינת 3

רשות מספר 1

מאמינה שהמחלקות צריכות לתכלל את הנושא של אזרחים ותיקים.

העיר מאוד מזדקנת – האיזון הופר בין ילדים למבוגרים.

יש הרבה מעבר למרכז העיר איפה שהשירותים זמינים

יש עמותה מקומית לרווחת הקשיש שנתמכת על ידי העירייה – יש רצף של שירותים משירותים לעצמאיים בשכונות והם העוגן והם דחיקת תלות משמעות ושייכות משם צריך להתחיל

בכל שכונה מועדון – זה החזון – גם שהם יפעילו בעצמם הרבה פעמים, גם בקורונה זה ריכך את הנפילה – רק נשים!! כמעט אין גברים. גברים באים להרצאות ופעילויות נקודתיות. במרכזי יום וניצולי שואה הם מגיעים ביציאה לפנסיה הם פחות צורכים שירותים חברתיים

יש להם רק 3 לא מספיק – כל גן שסוגרים היא רוצה להפוך למועדון

קשה מאוד מאוד להשיג כוח אדם וגם ללל תשלום ראוי

יש מרכז יום כולל אגף מוגן ושם רואים את הגידול מעל גיל 75

בתוך בית האזרח הוותיק שמתכלל את כל פעילויות הפנאי והקהילה פעילויות פנאי וספורט – הכי הרבה זה ספורט זה טריגר משמעותי להגיעה, הרבה

יש שתי קהילות תומכות בערך 200 איש, מאמינה שזה יקפות כשזה יהיה חלק מהגמלה

לא לשאול אם רוצים לקבל בכסף למה להציע, תיזמו שיחה תפרסו את השירותים ורק אז לשאול, כיום זו השאלה הראשונה שנשאלת ולא נעשה שיח אחכ.

קהילה תומכת – שירות מצוין שמאפשר להגיע להרבה מאוד אנשים בגלל הלחן מצוקה -יש מורכבות כי הם לא רוצים לפתוח תיק ברווחה בשביל סבסוד- אני היא דווקא אוהבת לפתוח להם תיק כי אז היא מכירה אותו ויכולה להציע לו אפשרויות ולהכיר אותו

בעבר הכירה אותם דרך חוק סיעוד היום היא פוגשת אותו רק בהתדרדרות והמטרה שלה היא למנוע את ההתדרדרות

הקהילה מופעלת על ידי העמותה המקומית ויש לזה יתרון עצום היא מפעילה גם את המרכז יום ובבית האזרח – יש ראייה כוללת ומתכללת והעמותה עובדת ישירות עם הרשות המקומית = זה יתרון בעיקר קטנה ובעמותה מקומית – ככה הם לא מפספסים אפחד

הקהילה התומכת מאפשרת לה לשלוח זרועות יותר ארוכות

צריך לייצר דרך הקהילות התומכות תתי קהילות – יש בנין עם 5 דיירים מחוברים אז אפשר לייצר שם קבוצת תמיכה, קשר עם שכנים.

תמיד חסר הסעות – אם אפשר להכניס את זה לקהילה התומכת זה יהיה טריגר להצטרפות לקהילה התומכת

אינטראקציה אחד על אחד ען בן אדם –

היא רוצה מאתרות, דפיקה בדלת לשמוע מה קורה ודרך שם להוציא – מעבר להסתובבות של אב הבית

עצמאיים, ירידה, מרותקי בית – קריטי למניעת התדרדרות תפקודית להכניס אנשים הבייתה לשיחות/ פעילות ספורט הבייתה

בסבסוד של בטל"א להכניס מורה לספורט לגיל השלישי – לא פרא רפואי

להרחיב את שירותי רווחה מרחוק – יוניפר להכניס גם את זה לסל שירותים שפשר לקבל מיבטוח לאומי

הכי חשוב זה לדבר איתם

הקושי הוא היציאה הראשונית החוצה – אחרי שמתחילים לצרוך שירותים הופכים להיות צרכנים סדרתיים

שיקום – אנשים אחרי אשפוזים –

לא מספיק אנשים באים למרכזי יום – לייצר סניף שיקומי בתוך מרכזי היום – זה היה גורם לאנשים להגיע ואז הם כבר נכנסים נמשלבים ונותן מענה לאוכלוסייה

מועדונים חברתיים מתוקצבים כמו שצריך עם תקינה לכוח אדם כמו שצריך, הסדרה של מה התוכן, שעות פעילות רכזת מוסדר ומובנה עם פעילות מובנת, היום זה לא מוגדרת. יש רכזת לא מתוקצבת,

כל אחד עובד אחרת, אין אפילו הגדרה של כמה גמלאים לרכזת, היום יש לה על רכזת אחת 100 אזרחים ותיקים – לא רציני ולא אחראי לעשות אתזה

לחשוב ברצפים מעצמאים, תשושה, מרותקי בית ולהגיד שירותים ייעודיים לכל קבוצה

בונה שאלון לאוכלוסייה – לדעת מה מעניין אותם לצרוך – איזה תכנים

קשר עם קופח – בעבר היו ביקורי בית משותפים עו"ס ואחות לכלל האוכלוסייה

תיאום טיפול – נכנס רק במורכבים לא נכנסים כתפיסה לראות את כל האזרחים הוותיקים

הנגשה דידיטלית – הכל מעבר לראש של האזרחים הוותיקים הם לא מסוגלים להתנהל בעולם הזה – עושים המון סדנאות אבל יש עדין הרבה בעיות של אוריינות דיגיטלית

מיצוי זכויות – שיל עד הבית – מתנדבים שמגיעים אליהם הבייתה פרויקט ייחודי שלהם שאפשר

מתבססים הרבה על מתנדבים אבל בסוף גם זה מצריך רכזת

יש להם שירותים מתנדבים ייעודיים גם לנישם גם למוגבלויות. עשו פרויקט של בני נוער עם ספורט 2 בני נוער יוצאים עם קשיש לפעילות גופנית – אבל גם זה מצריך הרבה שעות עבודה ובסוף 20 איש מקבלים את השירות 15 מפגשים – היתה רוצה להרחיב

מה שחסר לה זה אסדרה-תקנים ודברים כמו שידוע שיש 30 ילדים פותחים כיתה וברור מה הכוח אדם

צריך הגדרות ברורות מסודרות של מיהם מקבלי השירות ומה המטרות

היא רוצה גמישות תקציבית כדי לתת לכל קבוצה תכנית מותאמת אבל היא רוצה אסדרה בתוך הגמישות

ומצד שני איפה צריך גמישות הם לא נותנים גמישות

וחלק מהדברים את לא יכולה לדווח – או שהתעריך נמוך מידי ואז הם משלימים כבר לבד או שזה יותר מידי פרטים ומידע שצריך לתת

היא כן מעריכה את הטוב אבל יש פה עוד שיפורים שצריך לעשות

תקורות – לא מתקוצב המשרד מתקצב רק פעילות ולא תקורות

מנסה להרים מוקד שייכות שם בנו מודל תקציבי שיש בו גם תקורה, אישור והקימו לא מחזירים להם את הכסף כי המערכת לא יודעת איך להחזיר את הכסף

בזכות המלחמה קיבלה נתונים על כלל האזרחים הוותיקים מה שיה מאוד חסר עד אז כי לא הכירה את כל האזרחים הוותיקים ברשות

שרביט קסם – רשת מועדונים בשכונות לייצר קהילות קטנות שהם מפעילים בעצמם להחזיר לאזרחים הוותיקים את הכוחות

תעסוקה – יש אנשים שרוצים וצריכים לעבוד ויש לחשוב בהיבטים האלה

בקצה הרצף – בריאות – תיאום אבחונים, מידע, תיאום תורים מאוד קשה להתסדר במרחב הזה – קיים מנג'ר שיעזור להם להתנהל במציאות הבלתי אפשרי

קהילות תומכות יכולות לעשות את זה אם יהיה יותר כוח אדם ולשם הכיוון שצריך ללכת אליו

קיים מנג'ר שיעזור לאנשים להתנהל

מרכזת את תחום האזרחים הותיקים במועצה, בכל יישוב יש עו"ס מרחבית שפועלות בכל התחומים ובמועצה יש רכזת ייעודית לכל תחום

מרכזת גם את היחידה לשלום הותיק

יש שיתופי פעולה עמותה למעו הוותיק של המועצה עמותה חזקה שמוציאה לפועל המון מתוכניות הרווחה שלהם לדוגמה קהילה תוכמת שיש להם שתי קהילות

שיתוף פעולה מאוד הדוק ועובדים יחד גם בחשיבה ותכנון

פרויקט תעסוקה ביתית לאזרחים ותיקים מרותקים פיזית או חברתית – נכנסים לשם כל מיני מפעילים שונים ובאים אליהם הבייתה אחת לשבוע, 10 מפגשים במימון והרבה פעמים זה ממשיך בפרטי

מועדונים חברתיים – יש בכל ישוב מועדון ותיקים משלו בחלק יש אפילו שניים לוותיקים צעירים ולוותיקים ותיקים

32 מועדונים מתוך 38 ישובים

יש מועדוני מופת ומועשר - 3

מרכז יום יש אחד בכל המועצה

יש שני יישובים ערביים שבכל אחד מהם יש מועדון ייחודי והנוסף באחיהוד

יחידה לשלום הוותיק – מעבר למקרי אלימות עוסקים בחינוך, הסברה ולתת מענה לפניות עושים אירועים לקהילה

יש פורמיום של מועדונים חברתיים – הרכזים הם מתנדבים מהיישובים אז עושים להם פורום של למידת עמיתים והכשרות, פורום של בתים סיעודיים (משפחותנים) שלא עומדים בכללי רווחה/בריאות

יש שתפ עם מועצה סמוכה לתחנה לטיפול פסיכולוגי – עשו בתוך הישובים קבוצות שיח לוותיקים ללא הגדרת נושא מראש כל קבוצה יוצרת לעצמה, התחיל בקורונה ונמשך

קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים עם בטל והעמותה

קבוצה לתמיכה בחולי פרקניסון ובני משפחה – משולב פעילות של ריקוד סלוני ועו"ס

קהילה תומכת – מרוצים מהמודל והתפעול של העמותה נגישים וגמישים – הצטרפו לסל הגמיש וכל פעם משרדגים תוכניות שנותנים ספורט, מנוי לקאנטרי, פעילות חברתית – בוקר של ביחד, לחצן מצוקה ששודרג לצמידון שמודד דופק ולחץ דם, אב בית מתוגבר וטיולים אחת לחודש. מי שנכנס לקהילה לא מתנתק, אפילו מפונים לא התנתקו מהקהילה,

יש קושי ביישוג כי אנשים לא רוצים לצרוך שירותים מחוץ לקיבות אבל עובדים גם איתם בשאיפה להגיע לכולם

מאז הקורונה מאוד קשה לגייס אנשים לצאת החוצה – אנשים צריכים שהפעילות תגיע ליישוב וגם אז קשה להוציא מהבית. עושים שיווק אבל אנשים לא מגיעים (זה רוחבי בכל האוכלוסיות) קושי לצאת מהבתים – גם כשיש לא באים

תעסוקה ביתית יש רשימות המתנה אין אפשרות לתת לכל הדורשים וגם להגביל רק 10 מפגשים

מימון ארוחות חמות, אין לה עובדי זיקנה ייחודיים – הכל יושב עליה

חושבת שהשירותים הקיימים טובים וכל פעם מחדשים

פתחו מרכז שירותים של העמותה ואז הכל יושב יחד ואז זה גם מונע סטיגמה אבל גם מאפשר מעבר בין השירותים לפי התקדמות הזדנה – הזדקנות במקום מבלי לזוז גם כשהמצב משתנה.

לא משנה מה יהיו כאלה שימצאו בעייתי לצורך שירותים

המוטיבציה של האנשים ממצב סוציו אקונומי מסויים לא נוכל לשנות אותה – אם המוטיבציה היא לחסוך כסף

דווקא בסוציו היותר גבוה אפשר להשפיע להציע שירותים יותר מותאמים – להציע שירותים כמו קדנדרה וכל השירותים בעצם תמורת נקודות של חוק סיעוד, קהילה תומכת עם סל גמיש

התקציב הגמיש שהם עשו לא זז, רוב הכספים צבועים גם ככה למרכז יום, לא באמת נתנו אפשרות לשחק זה אותה גברת בשינוי אדרת לא מבינה את השינוי, לא באמת מאפשר לה להמציא את עצמה מחדש ולתכנן

חסר לה הכשרות מקצועיות והדרכות מקצועיות חסר דברים ממוקדים לא באוויר של מדברים שייתו ותיאוריות אלא כלים פרקטיים חסר הדרכות של שוטף וזה ממש ממש חסר ונדרש.

לא יוצאים למכרזים עובדים בעיקר עם העמותה.

העמותה מתמודדת עם מרחקים ופקקים לפעמים הוציאו הסעות ב0600 כדי להגיע לארוחת בוקר ב073 ההסעות יקרות, מעבירים עכשיו את המרכז למיקום אחר שזה אמור לעשות שיפור קצת.

לכל עוס יש יום בשבוע שצריך להיות ביישוב שלו – אז פחות התרצוציות.

בחירום - למשרד הרווחה לקח זמן להיכנס לתמונה בחזית הצפונית. לקח שבועיים ובינתיים ראש המועצה תפעל את זה עצמאית את הפינויים

היה מאוד קשה לפנות אזרחים ותיקים עם בעיות בריאות וקניציה לא יכולו לעלות על אוטובוסים ונשארו אחרונים ביישובים שלהם

היום יש הרבה אנשים מפונים שעוברים לדיורים מוגנים מתוך הבנה שלא יחזרו בקרוב

היו להם שתי משפחתונים לפנות ועכשיו מחזירים למקומות אחרות

איך יוצרים במלון קהילה מחדש ממגוון ישובים – איך מוציאים אותם לעשייה מחדש עכשיו כשהם במלונות ומשתבבלים

היו 8 ישובים מפונים 19 מוקדים פינוי – כולם הפכו לקוחות רווחה כניסו צוותים ותקציבים למוקדי פינוי, פתחו מוקד טלפונים שיזם שיחות לכל הוותיקים של המועצה – היו חרדות גם אצל ישובים שלא פונו 5 קמ מהגבול – היה עמוס

עוד לא הגיעו לשלב של לשחזר מה למדנו מזה על השוטף כי האירוע עוד בעיצומו

היתה רוצה לשבת ולעשות תוכנית מוסדרת – חושבת שהיו צרכים לעשות מיפוי צרכים יותר רציני ועבדו יותר מבולגן ובכפילויות – עד היום הכל מבולגן קשה לתכנן תוכניות והרבפעמים גם כשתכננו לא נתנו להוציא אל הפועל

ייחודיות של אוכלוסיה ערבית – שני ישובים שונים אחד של דרוזים שמאוד משתפי פעולה והישוב השני מוסלמי אבל בחרו להיות חלק מהמועצה וחלקפעיל יש מורכביות כי יש צרכים אחרים – המרכז יום של המועצה לא מתאים להן, יש צרכים ייחודיים להם ואופני חיים ייחודיים, כל הזמן עסוקים בלהבין את התרבות מה נקודת המפגש מתי צריך לעשות התקרבות לתרבות שלהם, הם קודם רוצים לקבל ואז לתת

המטרה שלה שהוותיקים שם יהיו מוגנים פעילים וייתנו בה אמון למקרים חריגים – זה דורש הרבה עבודה

שיתוף פעולה עם משרד הבריאות עובדים עם קופח פחות. יש להם עובדת הרווחה שרכזי בריאות התפקיד שלהם לתכלל מענים פראיים במעוצה וזה בעיקר דרכם יש קשר שוטף עם לשכת בריאות

החלום שלה – מקנאה בערים שיש מחלקה לוותיקים שזו ממש מחלקה מתמחה ומתמקדת שיכולה להוציא יותר דברים אל הפועל – כשיש צוות מכון זקנה יותר קל להרחיב היתה רוצה להרחיב עבודה קהילתית ובני משפחה מטפלים – היינו מוציאים עוד הרבה שירותים.

רשות מספר 3

עו"ס 20 שנה במועצה אחראית אזרחים ותיקים עובדת בשת"פ עם עמותה שמפעילה את רוב השירותים 14 יישובים במועצה כולל ישוב ערבי אחד

לכל ישוב במועצה יש עו"ס שנותנת שירותים לכל האוכלוסיות – עובדים במודל מרחבי של 0-120 בכל יישוב, היחידה למינעת התעללות (מוגנות האזרח הוותיק) פיזית, כפסי מילולי, מיני יש יחידת התערבות קהילה תומכת – אם אב הבית מזהה משהו מיד פונה לעו"ס

מועדון מופת

מועדונים ביישובים

מועדון מועשר

אין ניצול שואה – אין הרבה אז אין משהו ייחודי

כמעט בכל ישוב יש מועדון חברתי

יש בתים חמים

פעילות של העמותה – כמו סוג של מתנס חוגים העשרה רק לוותיקים – אם מישהו פתאום מפסיק להגיע לחוג אז גם מעדכנים

הייחודיות שלהם זה שהם מכירים את האוכלוסייה שלהם, בכל ישוב יש רכז בריאות ורווחה של היישוב שעובדים בשתפ עם המשח

לא יקרה מצב שלא יגלו קשיש שמת

הדבר הכי גרוע שעשו זה שהעיברו את חוק סיעוד מהרווחה לביטוח לאומי – הם עובדים יפה עם הסניף אבל זה עדין הרחיק אותם מהשטח ומלדעת בדיוק את מצבו של כל מקבל ולטפל בו בהתאם

בני משפחה מטפלים – אין להם יחידה או רכז ייעודיים זה אצלה גם – אבל הם עושים סדנאות בתחום גם לילידים שלא גרים במועצה אבל ההורים שלהם גרים במועצה

עובדים עם העמותה על הזדקנות מיטבית

נכנסים למועדונים ביישובים ובשטח

קהילה תומכת – כמעט מילאו מכסה ולקראת פתיחה נוספת. גולת הכותרת הוא אב הבית – הוא דמות המפתח להצלחה של הקהילה שמעבר ליכולת טכנית יש לו נשמה של עו"ס, כולם יודעים לפנות אליו והוא יודע להפנות בחזרה, עבודה טובה מול החברה שנותנת שירותי בריאות

פעילות חברתית יותר מוטמעת ביישובים ולא בקהילה – בגלל שהם מועצה אזורית זה מרחקים קשים לעשות דברים ויש יותר השתתפות כאשר היישוב מוציא ולא המועצה.

אתגר הסל הגמיש – מרגישה שיש דברים טובים שעובדים יפה ואז מישהו מלמעלה בא עם איזה רעיון ומקלקל

במועצה האזורית אין היצע של שירותים כמו קאנרטי והצגות שאין לה לתת להציע לאזרחים הותיקים כמו במקומות אחרים

אם משאירים את אב הבית + השירות הרפואי זה לא משאיר הרבה לדברים אחרים

הבחירה מאוד דלה והתקצוב מאוד נמוך ואז יהיה מצב שאנשים יבחרו לא לקחת שירות רפואי וזה מילכוד וגם יש יותר מידי אפשרות לעבור כל רבעון שירות

השירות הרפואי הוא קריטי מאוד עבורם והם משתמשים בזה ולא יהיה להם למי לצלצל כשמרגישים לא טוב

הם רגילים לחיות בקהילה – בעיר כל אחד מתנהל עם עצמו – בקהילות אזוריות זה עובד אחרת בטח בקיבוצים ולחייב לעבור למשהו זה בעייתי.

הם עושים כמה מופעים בשנה לאזרחים ותיקים וחברי קהילה תומכת נכנסים בחינם – והעלויות הן גבוהות אם רוצים להביא אומנים ראויים ואז הסעות מהיישובים

מרגישים שממציאים שירותים כדי להתאים לסל הגמיש הנדרש

חשובה אפשרות הבחירה אבל לפעמים היא יכולה לייצר נזק גם לאדם וגם למסגרת

גמלה בכסף למול גמלה בשירותים – כמעט כל מי שהם מכירים לקח לפחות את המינימום ואחכ עושים מאמץ לקבל שליש בכסף – חלק קונים בכסף מנקה ורוב האנשים אבל משתמשים בזה לשגרה ולא צורכים בזה שירותים, אחכ לוקחים מטפלות שזה בעייתי – כמו השעות של המטפלת היא מזערית והיא מרגישה שיש שם הרבה רמאות יש 10 שעות ועושים שעתיים ואפחד לא עושה משהו למרות שכולם יודעים אבל אפחד לא רוצה לעשות עם זה משהו.

בגלל שהם מועצה יחסית קטנה אין להם מספיק אזרחים להקמת מרכז יום שאפשר להמיר אליו חוק סיעוד וגם מי שבחר את זה שהם בודדים אין להם הסעה אז הם משתמשים ב3 מרכזי יום טובים חיצוניים אבל האוכלוסיה מצומצמת ובסוף מוציאים המון כסף על הסעות. במקרים שהם מרגישים שזה חובה שייצאו אז הם עושים הכל כדי להוציא לשם כולל מימון הסעות

יש מועדונים ביישובים שמכילים גם את המטופלים המורכבים יותר והסיעודיים יותר בלי זה אנישם היו יושבים בבתיים

רוצה תקצוב להסעות ולא על חשבון אותו פול

גמלת סיעוד לא נותנת מועדון מופת ומכניסים גם קצת רמה 3 כי אין חלופה

רוצים עוד מועדוני מופת

התקציבים היום עובדים במודל סל גמיש – הם מקבלים סל גמיש – סל אחד לכל השירותים אם היא רוצה להקים משהו חדש זה בא מאותה עוגה לא מקבלת תקציב אקסטרה לשירותים חדשים

בני משפחה מטפלים דרך חוק סיעוד – לפעמים זה משרת כי גם ככה בני המשפחה מטפלים ויש משפחות שזה פשוט דמי כיס לנכדים והטיפול נפגע – זה לא מגיע להזנחה – אבל אפשר היה אחרת

צריך שרק כשצריך עובד זר אז לקחת את הכל בכסף

אצלם מי שזקוק קונה מוצרי ספיגה

אם תהיה קהילה תומכת דרך חוק סיעוד זה יעשה אצלם שינוי

ברגע ששמים לאנשים כסף מול העיניים אין הרבה סבירות שייקחו שירותים

שתפ עם קופח – בגלל שהיא מחזיקה גם את תיק בריאות בחירום – בכל ישוב יש מרפאה קטנה של הכללית – שתפ גבוה בתוך הישוב עצמו מול העוס של היישוב וגם מולה

מודלים שעובדים מצויין של ישיבות צוות משותפות – המרפאות קטנות ולפעמים יש חוסר בכוח אדם שמקשה על האזרחים הותיקים ואז צריך להסיע אותם למרפאה

מוקש גדול שאין תחבצ במועצה האזורית

מודל ההפעלה – עמותה אחת - מועצה אזורית ידועה בשתפ

הקהילה התומכת מנוהל בעמותה מבחינה כלכלית העמותה הם גורם מפעיל אבל העבודה בשיתוף פעולה מלא. הן עובדות על הכל ביחד גם יושבים יחד כל פעם מישהו אחר מוביל אבל זה שת"פ עמוק

זו עמותה של המועצה זה לא מטב שזוכים במכרז – יש פה זהות אינטרסים ואין תחושה של ספק

מאוד רוצה קאנרטי ופעילויות ספורט ובריכה, רוצה לאפשר לכל בן אדם מה שהוא רוצה יותר מגוון בחירה ואפשרויות

עובדים איתם על פרויקטיביות עושים קורסים לאזרחים ותיקים שמאפשרים להם אחכ להוביל תחומים באזור מגוריהם

היו רוצים גם אפשרות של בישול ואפייה במועדון – המבנים והמתקנים לא מתאימים

העו"ס היום פחות מטפל אלא יותר מתערבים ומפנים – יש להם מרכז מפגשים מרכז טיפולי נרחב לכלל האוכלוסייה – פחות ותיקים מגיעים יש פחות עבודיפ בתחום הזה ועוד פעם מגיעים לנשוא של הסעות

יש צורך אצל אזרחים ותיקים בטיפול רגשי/סוציאלי יש קושי גם בהשגת עובדים וגם בהסעות

יודעים להפעיל את עמך למי שמתאים לו.

רוצה יותר מופ"ת יותר מבנים מתאימים – היום פועלים במבנים לא שלהם, ואין פסיליטיז / **תשתיות** מתאימים גם להופעות והרצאות עושים בחדרי אוכל ואולם התעמלות

מכניסים סדנאות וכו' דרך תקציבים קיימים

המרכז יום זה החיסרון הכי גדול עבורם וצריך יותר מועדוני מופת ושלא יקלקלו את מה שעובד טוב – לנהל שיח מול הרשויות אולי לא כל רפורמה מתאימה כל מקום.

יוניפר יש ממש מעט אבל זה לא מחליף טיפול

העמותה גם יודעים להפעיל זומים וכאלה לפעילויות

רשות מספר 4

שמחה מאוד על ההזדמנות לשתף, יודעת לדבר רק על עצמה 50 אלף תושבים 11,000 אזרחים ותיקים מתוכם 1400 ניצולי שואה, שמוכרים להם שמית אחד אחד, קרוב ל80% מהאזרחים הותיקים עולים, חלק גדול מהאוכלוסייה, אוכלוסייה מוחלשת כלכלית שמתקיימת מהשלמת הכנסה מביטוח לאומי

יש להם היום מגוון שירותים לאוכלוסייה זקנה

המון שירותים לאוכלוסייה מבוגרות – 2 מרכזי יום שנותנים מעניה לתושביש נפש, מרכז יום לתשושים קשים/כמעט סיעודיים 3 מועדוני מופת חברתיים אחד לבני עדה אתיופית ואחד מועדון ייחודי בארץ לאזרחים ותיקים כבדי ראייה

קהילה תומכת שלא מצליחה להתרומם, יש אישור ל400 השמות בפועל יש רק 60 ולא מצליחים לעלות

יש בתים חמים שמאוד משגשג בכרמיאל יש 12 בתים חמים ושוקלים לפתוח בית חם נוסף

בית אבות

יש להם סל גמיש ומפתחים תוכניות קהילתיות

הקשיים בסל גמיש זה המציג קיבלה אישור להפעלת תוכנית שהגישה ובפועל נמסר לה על ידי העירייה שאין מספיק כסף למצ'ניג אז רק חצי מהתוכנית תצליח לצאת לפועל

תוכניות קהילתיות – זיהו שכל התוכניות מותאמות לקשישה מובגרת מאו, מי שמגיע לשם בדרכ 80+ ויש פער בין יוצאים טריים לגמלאות עד סביבות גיל 78 שלא מוצאת את עצמה מבחינת הפעילויות והמסגרות – לא מתאימים למרכז יום, רוצים פעילות מותאמת גם לא מתאים להם מועדון חברתי כי לא רוצים 3 פעמים בשבוע בשעות קבועות, רותים חוגים, הרצאות פרלמנו, צריכים המון התעסקות סביב נושא של פרישה לא הכנה לפרישה כלכלית אלא פרישה בתובנה הרגשית וההשלכות הרגשיות של הדבר הזה, בדרכ פוגשים אותם אחרי פיתוח פתלוגיה כי לא ידעו להתמודד עם הפרישה והם רצו לפתח מענים לאוכלוסייה הצעירה הזאת שמותאמים להם ומה שעשו בשנה וחצי האחרונה פיתחו תפקיד שנקרא רכז גמלאים – הפך למלווה קהילתי במסגרת מוקד שייכות שמטרתו להגיע לאנשים שלא צורכים שירותים קלאסיים ולפתח

עשו ריכוז של כל התוכניות – יש המון גופים שפועלים ברשות למען אזרחים ותיקים ולא יודעים אחד על השני ולא מגיע לאזרח הותיק, גמלאים של הסתדרות, מתנסים, עמותה מקומית, איורעים של הרווחה, ויצו נעמת וכו שעושים פעילויות ורוב הפעילויות פתוח לכל האזרחים הוותיקים בעיר פשוט האזרחים הוותיקים לא מודעים לזה, פעם בשנה מוציאים חוברת עם כל הפעילויות ברמת העירונית וכל אחד יוכל להשתבץ

עשו היכרות בין כל הארגונים שיש להם נגיעה באזרח הותיק כולל ביטוח לאומי וקופות חולים, שכולן פגשו את הרכז כדי שהיא תהיה צומת של העברת מידע ואז היא ידעה להפיץ דברים בקבוצות וואטספ של אזרחים ותיקים שהעירייה פתחה

דבר נוסף שבנו – גייסו אזרחים ותיקים שמעבירים חוגים למען אזרחים ותיקים וזה היה בחינם לשאר המשתתפים

התחילו לפתח גם סדנה בת 8 מפגשים לפורשים צעירים בשתפ עם בטלא שיש גם התייחסות לתכנון כלכלי ולחבר לזה את התחום הרגשי.

יש קבוצה של אזרחים ותיקים שרצו אוריינות דיגיטלית קיבלו קול קורא ממערך הדיגיטל ועשו 3 קבוצות של אזרחים ותיקים שקיבלו סדנאות של 18 מפגשים של אוריינית דיגיטלית.

למה התבים החמים מצליחים? התחילו כבר לפני 7 שנים עם 6 בתים חמים זה פשוט הלך וצמח גם בזכות הדמויות המפעילות וכבר יצא לו שם טוב – אנשים שומעים וגם העובדים מאוד מאמינים במקום, קלטו המון קשישים מהמלחמה באוקראינה, יש חיברו אותם לבתים חמים לצורך השתייכות חברתית והבית החם הוא מן משענת עבורם כי יש שם ליווי צמוד, קבוצות מגובשות שמקבלים את כל מיש מצטרף פותחים בית חדש לאוכלוסייה כבדת ראייה אבל צעירים יותר ודוברי עברית לעומת המועדון שכבר קיים

בתים חמים בהפעלה ישירה של המחלקה וגם ההוצאות הכספיות, מתקצבים בית חם ב-500 שח לחודש לקפה מאפה והוצאות קטנות והעירייה נותנת להם את מקום המפגש, יציאות משותפות לבית קולנוע, הרצאה שמבקשים

מחפשים קבצות של מכנים משותפים

מצליחים הרבה פעמים בזכות סטודנטים שעובדים איתם ועוזרים להם לעשות פרויקטים חדשים

למה קהילה תוכמת לא קמה? יש עניינים שקשורים להשקעה ולכוח אדם ושיווק שהעמותה שמפעילה לא מאמינה בשירות הזה ולא נותנת לזה מספיק תשומות של כוח אדם ושיווק, כרגע בשלב של יציאה למכרז/הסכם ביניים להחליף עמותה/חברה

העמותה היא אותה עמותה עירונית שנותנת אצלם את כל רצף המענים לאזרחים הותיקים ולכן רצו כל פעם לתת לה עוד הזדמנות

הוא לא רווחה לעמותה כי עבור כל השמה תומכת המשרד מתקצב 157 והטענה שלהם שהעסקה של כוח אדם נדרש והשירותים שנדרשים לתת למקבל השירות – אבל היא חושבת שאולי זה כן יכול להתכנס ולענן רוצה מפעיל אחר. ברמה העקרונית היא חושבת שברגע שזה מתרומם זה נהיה יותר רווחי

מאמינה בקהילה תוכמת מאוד אבל חיים גורם מפעיל בגלל שיש העסקת כוח אדם בקרה ופיקוח שהם לא יכולים לקחת על עצמם

הנושא שהכי כואב לה זה המצ'ינג בסל גמיש, השקיעו ובנו תוכניות לאנשים מרותקי בית, והם לא יכולים להפעיל אותן בגלל המצ'ינג ולעירייה אין תקציב

כוח אדם – על הנייר לא חסרים לה תקנים אבל בפועל יש מחסור בתקנים כי עובד זקנה בחצי משרה צריך לתת מענים ל-120 משפחות (בודדים וזוגות) העובדים לא מחפשים מטופלים חדשים כי אין להם זמן לריצ'ינג אוט

מטופלים בני משפחה הפך לפרנסה לילדים ואז הילד לוקח חלק מהקצבה בחלק שלא יכולים לקחת בכסף רושם כמטפל את הבת שלו והם תמיד יעדיפו לתת כסף לילדים מאשר ללכת לפעילות, הם יכולים להתערב רק במצב של סיכון והזנחה ואז יכולים לפנות לביטוח לאומי

מתקיימת כזו שיחה מקדימה עם העו"ס של ביטוח לאומי לפני שהאזרח מחליט איך לנצל את הקצבה חייבים להציע כסף, **חייבים לקבל את הילד לעבודה** – הם כן מעלים שטובתו היא לצאת לשירותים, ברגע שיש בחירה השיקול הוא בסופו של דבר מול הפרנסה של הבת למול לוותר על מרכז יום, לא אתקלח כס יום, בקורונה זה מאוד בלט, כשהם חילקו ארוחות חמות בסגרים וראו שמלא מבוגרים שרשמו את הבת כמטפלת למרות שלא נתנו שירות בפועל כמטפלות.

קהילה תומכת עם סל מורחב לדעתה אמור לשכנע אנשים לקחת שירותים במקום קצבה אבל כרגע זה לא נכנס לביטוח לאומי

מהש היא רואה שני דברים שחשובים לפיתוח ופתרונות – אזרחים ותיקים צעירים ולבנות תוכניות מניעתיות לצורך מניעה כי זה יפתור וייתן להם איכות חיים ולדחות את השלבים של

התערבות יותר משמעותי שיצטרכו לתת בעתיד, מענים בתחום: בריאות ספורט, תעסוקה, חברה

נושא שני שמעסיק אותה זה נושא של מרותקי בית שאין מספיק תוכניות במשרד שנותנים מענה נכון והולם לאוכלוסייה הזאת – כל השירותים הם מחוץ לבית

יש לה תקציב נפרד לניצולי שואה ששם היא יכולה לפתח יותר כי אים מצ'ניג אז פיתחו שירת עם מרפאה בעיסוק למרותקי בית שבונה תכנית להדרכה תעסוקתית ואז יש מדריכה תעסוקתית שמגיע אחת לשבוע ועובדת איתם. פעם בשבוע אדם נייטלי שמגיע ורואה את הקשיש ועיניים אוזניים של המחלקה נותנים שירות שמשמר תפקודים פיזיים וקוגניטיביים תוכנית מותאמת אישית לאותו אדם. ואז זה באמת מותאם.

יש הרבה תוכניות שאפשר לבנות אבל לא מתקצבים מהמשרד